GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC 000.344/2021-4 [Apenso: TC 006.259/2021-9]
Natureza(s): Representação
Órgão/Entidade: Ministério da Saúde, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amazonas
Representação legal: não há

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE RECURSOS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FALTA DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO AOS PACIENTES HOSPITALIZADOS NO ESTADO DO AMAZONAS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. CONHECIMENTO. CONDUTA DOS GESTORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APURADA EM OUTROS AUTOS. JUNTADA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Representação efetuada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos e na prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em função da falta de fornecimento de oxigênio aos pacientes hospitalizados no estado do Amazonas em decorrência da covid-19, no mês de janeiro de 2021.

2. A unidade técnica assim se manifestou:

"*HISTÓRICO*

1. A representação, datada de 18/1/2021, aborda o aumento de contágio por Covid-19 no Amazonas, que elevou o número de internações, fazendo com que a taxa de ocupação de leitos hospitalares ficasse próxima de 100% e provocasse significativo incremento da demanda por oxigênio medicinal (peça 4).

2. O representante acostou matéria jornalística noticiando que o consumo de oxigênio, no dia 12/1/2021, atingiu 70 mil metros cúbicos, ultrapassando a média diária de 15 mil a 17 mil metros cúbicos, e que esse consumo superava a capacidade diária de fornecimento das três empresas fornecedoras da cidade de Manaus, cujo volume máximo diário alcançava 28 mil metros cúbicos.

3. Acrescentou que, em função dessa situação crítica, o governo federal adotou medidas urgentes em conjunto com o governo do estado do Amazonas para tentar suprir a rede hospitalar com insumos e oxigênio, mas tais medidas podem não ter sido suficientes para evitar a grave crise instalada naquele estado.

4. Uma das medidas citadas foi o transporte de cilindros de oxigênio pela Força Aérea Brasileira, conforme matéria divulgada, em 15/1/2021, no sítio desse órgão.

5. O representante juntou ainda matéria da Folha de São Paulo, publicada em 16/1/2021, noticiando que o governo federal teria ignorado alertas em série sobre falta de oxigênio em Manaus, uma vez que a empresa fornecedora, desde o dia 7/1/2021, vinha comunicando o excesso de demanda, tendo o governo federal tomado ciência do fato, pelo menos, desde 11/1/2021.

6. Ao final, a representação apresentou proposta para (peça 4, p. 11):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

a. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VI, c/c 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014;

b. diligenciar a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de cinco dias úteis, apresente esclarecimentos e informações acerca dos seguintes pontos relacionados ao colapso no sistema de abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais estaduais e federal localizados na cidade de Manaus:

b.1. falta de planejamento para prever e lidar com a escassez de oxigênio medicinal no Amazonas, medidas efetivamente adotadas para debelar a seríssima crise sanitária instalada em Manaus, capital do Amazonas, em especial com o fim de suprir os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes;

b.2. informações acerca do prognóstico de abastecimento de oxigênio medicinal em todo o Brasil para lidar com a pandemia, em especial para os demais estados da região Norte do país;

b.3. informe, considerados os recursos que a Pasta vem transferindo aos entes subnacionais para enfrentamento da Covid-19, quais os instrumentos o MS utiliza (planejamento e supervisão, com encaminhamento de documentação probatória) para controlar a destinação dos recursos recebidos pelos entes subnacionais, não somente para prever e ter controle sobre o abastecimento de insumos críticos, mas também para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal);

c. diligenciar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, com fundamento no artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de cinco dias úteis, apresente esclarecimentos e informações acerca da situação crítica do hospital universitário Getúlio Vargas, no tocante a insumos para enfrentamento da Covid-19, em especial, o abastecimento de cilindros de oxigênio.

7. O Ministro Relator, em Despacho de 19/1/2021, autorizou a realização das diligências propostas (peça 6).

8. Os ofícios de diligência foram encaminhados (peças 7-8), com ciência em peças 9-10.

9. O Ministério da Saúde pediu prorrogação por mais 5 (cinco) dias úteis (peça 11), sendo acolhido o pedido pelo Tribunal (peça 14). A resposta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) consta das peças 12-13 e a do Ministério da Saúde nas peças 16 e 19.

10. A instrução de peça 28 analisou as respostas de diligência do Ministério da Saúde e da Ebserh, e concluiu pela necessidade de realizar diligências adicionais ao Ministério da Saúde, Ebserh e Governo do Estado do Amazonas, e solicitação de processo do Ministério Público Federal, com anuência da direção da Unidade Técnica e do Ministro Relator (peças 28-31), nos termos a seguir:

27. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

a) realizar diligência a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 10, §1º, e 11 da Lei 8.443/1992, e no art. 157, do RI/TCU, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a este Tribunal:

a.1) informações da existência ou da elaboração de plano de contingência nacional para enfrentamento de situações de excesso de demanda de leitos para Covid-19, nos estados brasileiros, para que não haja falta de atendimento de pacientes, seja pela ausência de estrutura física, por falta de profissionais ou falta de insumos médico-hospitalares, como ocorreu com a falta de oxigênio medicinal em Manaus/AM e Faro/PA, em janeiro de 2021;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

a.2) o ofício do governo do estado do Amazonas solicitando a suspensão do apoio para transporte de cilindros de oxigênio para Manaus, em janeiro de 2021, como informado no Despacho SE/GAB/SE/MS, de 3/2/2021;

b) realizar diligência a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, com fundamento nos arts. 10, §1º, e 11 da Lei 8.443/1992, e no art. 157, do RI/TCU, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a este Tribunal:

b.1) informações se o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) estava com estrutura preparada, em termos de recursos humanos e insumos necessários, para abertura de 17 (dezessete) leitos de enfermaria e 10 (dez) leitos de UTI, em 30/12/2020, para pacientes de Covid-19, uma vez que havia orientação da direção central para abertura de 10 leitos de UTI, e o hospital não era mais referência para essa doença desde 30/7/2020;

b.2) os estudos de viabilidade para atendimento dessa demanda, em termos de profissionais, equipamentos, medicamentos e insumos médico-hospitalares, especialmente oxigênio medicinal, se houver;

b.3) informações sobre a cessão de dois andares do HUGV, em janeiro de 2021, para Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas para abertura de 108 (cento e oito) leitos de enfermaria e mais 10 (dez) leitos de UTI para pacientes de Covid-19, indicando com os documentos comprobatórios:

b.3.1) o mantenedor desses leitos em termos de recursos financeiros, profissionais e insumos médico-hospitalares (Ebserh ou governo do estado);

b.3.2) se todos esses leitos foram ocupados no mês de janeiro e se ainda persiste a cessão, bem como a sua ocupação atual;

b.3.3) se foi previsto no contrato com a White Martins esse aumento de pacientes, uma vez que afetaria o consumo de oxigênio ou esse insumo seria fornecido pela secretaria de saúde;

b.3.4) se foi celebrado o contrato de cessão desses andares;

b.4) informações com quantitativo diário de pacientes com Covid-19 internados, clínicos e UTI, no período de 1º/1/2021 a 31/1/2021, bem como de pacientes falecidos nesse período;

b.5) o processo do Pregão Eletrônico 22/2020, de agosto/2020, com o seu termo de referência e estudos preliminares, e:

b.5.1) esclareça se o volume homologado de 100.648 m^3 de oxigênio medicinal contratado junto a White Martins, era para fornecimento ao HUGV anual, mensal ou diário, pois não foi informado na resposta de diligência anterior;

b.5.2) informe o histórico de consumo diário de oxigênio do HUGV, em 2020, e no período de janeiro de 2021;

b.5.3) informe como é feito o pagamento do oxigênio medicinal, se por quantidade e valor fixo ou se por demanda, com valor variável pelo seu consumo, ou outra forma acertada, bem como qual tipo de controle é realizado pelo hospital para aferir o quantitativo consumido e faturado;

b.5.4) informe se a empresa White Martins atendeu com fornecimento de oxigênio medicinal, de acordo com a demanda contratada. Em caso negativo, quais as providências adotadas?

b.6) informações de transferência de pacientes com Covid-19 para outros hospitais da rede Ebserh indicando:

b.6.1) se esses pacientes seriam referenciados do HUGV ou de outras unidades da rede estadual de saúde;

b.6.2) se existe estudo que avalie se o quantitativo de pacientes com Covid-19 transferidos não venha sobrecarregar a unidade hospitalar recebedora;

c) realizar diligência a Secretaria Estadual de Saúde do estado do Amazonas, com fundamento nos arts. 10, §1º, e 11 da Lei 8.443/1992, e no art. 157, do RI/TCU, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a este Tribunal:

c.1) informações sobre o volume de oxigênio diário consumido pelo estado do Amazonas, separando capital e interior, no período de 1º/7/2020 a 31/1/2021;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

c.2) informação de quando tomou conhecimento que a empresa White Martins não teria condições de atender a demanda excedente de oxigênio, que acabaram por levar ao desabastecimento da rede de saúde;

c.3) os estudos preliminares para elaboração do projeto básico para celebração do 7º Termo Aditivo ao Contrato 61/2016, celebrado com a empresa White Martins, para fornecimento de oxigênio medicinal, bem como o termo de referência, aditivos e contrato citados;

c.4) informações sobre a existência de plano de contingência para situações de aumento expressivo de leitos para Covid-19 que poderiam ocorrer a partir das festas do final do ano de 2020, apresentando-o, caso exista;

c.5) justificativas pela não comunicação ao Ministério da Saúde, em novembro ou dezembro, sobre a possível situação de desabastecimento de oxigênio em Manaus, que poderia ocorrer no início de janeiro de 2021;

c.6) informações da situação atual da capital e dos municípios do interior em relação ao abastecimento e consumo de oxigênio (ocupação de leitos, consumo de oxigênio diário, empresas fornecedoras e volume fornecido);

c.7) informação da existência ou se está sendo elaborado um plano de contingência para enfrentar nova situação de excesso de demanda por leitos de Covid-19 no ano de 2021, caso ocorram novas ondas de contaminação de Covid-19.

d) Solicitar da Procuradoria da República no estado do Amazonas que disponibilize o processo 1.13.000.000061/2021-04, que trata de procedimento sobre a falta de abastecimento de oxigênio medicinal em Manaus, em janeiro de 2021, com amparo no Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCU e o MPF, em 6/6/2018;

e) encaminhar ao Ministério da Saúde, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, à Secretaria Estadual de Saúde do estado do Amazonas e à Procuradoria da República no estado do Amazonas cópias da presente instrução a fim de subsidiar suas respostas.

11. Os ofícios de diligência constam das peças 32-37, as ciências nas peças 38 e 73, o pedido de dilação de prazo do Governo do Estado do Amazonas e seu deferimento (peças 75-76), com resposta da Ebserh (peças 39-72), do Ministério Público Federal (peça 74), do Ministério da Saúde (peça 80) e do Governo do Estado do Amazonas (peças 81-101).

EXAME DE ADMISSIBILIDADE

13. Considerando que a presente representação ainda não foi formalmente conhecida sua admissibilidade nos termos dos artigos 235, parágrafo único, e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), reiteram-se os fundamentos apresentados na instrução inicial, conforme excerto abaixo (peça 4):

9. As unidades técnicas do tribunal possuem legitimidade para representar à Corte de Contas e a matéria objeto da presente representação refere-se a administradores sujeitos à jurisdição do TCU, o que atende os requisitos dos artigos 235, parágrafo único, e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU).

10. No tocante ao requisito de a matéria ser de competência do tribunal, vale destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

11. Conforme previsão constitucional, a responsabilidade quanto aos cuidados da saúde é comum entre os entes federativos:

Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

12. A legislação determina a responsabilidade solidária entre os três entes federativos na prestação de assistência à saúde. A Lei 8.080/90, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, estabelece em seu artigo nono que:

Art. 9º A direção a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

13. Embora a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estabeleçam como princípio a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal, conforme o art. 16 da Lei 8.080/90, cabe à direção nacional do SUS, a cargo da União, entre outras competências, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária.

14. Além da previsão constitucional e legal, esse entendimento acerca da responsabilidade solidária dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população é reproduzido em ampla jurisprudência do Judiciário brasileiro que envolve o tema. Nesse sentido: RE 855.178, AI 822.882-AgR, Rel.Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274- AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffol; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010).

15. Vê-se, portanto, que, embora as responsabilidades pela gestão e prestação de serviços de saúde na rede de média e alta complexidade do estado do Amazonas e do município de Manaus sejam, respectivamente, dos Governos do estado e do município, a União e, consequentemente, o Ministério da Saúde, possui responsabilidade pela coordenação e supervisão do sistema. Ademais, é certo que boa parte dos recursos geridos e aplicados pelo estado e pelo município na manutenção dos serviços de saúde hospitalares são oriundos do Fundo Nacional de Saúde e transferidos fundo a fundo aos entes subnacionais.

16. Pelo exposto, conclui-se que a matéria é de competência do tribunal, existe o interesse público no trato das ocorrências, dada a situação crítica no atendimento aos pacientes na rede pública de saúde no estado do Amazonas, bem como existem indícios concernentes às irregularidades a serem apuradas pelo Tribunal, conforme exige a Portaria-Segecex 12/2016 c/c art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014.

EXAME SUMÁRIO

14. De igual modo, a instrução inicial realizou o exame sumário acerca do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos narrados nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, nos termos abaixo (peça 4, p. 5):

18. Acerca da materialidade envolvida, não é possível quantificar o volume de recursos envolvidos na aquisição do oxigênio medicinal. Não obstante, rápida consulta ao portal localizaSUS mantido pelo Ministério da Saúde informa que foram repassados ao Estado do Amazonas, a título de recursos para enfrentamento da Covid-19, aproximadamente R$ 512 milhões, dos quais R$ 167 milhões para a Secretaria Estadual de Saúde (SESA/AM); R$ 33 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde da capital; e R$ 312 milhões para as demais secretarias municipais de saúde). Assim, ainda que não seja possível aquilatar neste momento as destinações específicas dos recursos recebidos, certo é que há alta materialidade de recursos envolvida.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

19. Com relação ao risco, a situação caótica existente nos hospitais do estado do Amazonas e na cidade de Manaus aumenta a possibilidade de mortes e aponta para eventual omissão e falha na coordenação das ações de enfrentamento à pandemia pelo Governo federal, representado pelo Ministério da Saúde. Ademais, eventual caracterização de má gestão pode indicar que situações como a ora relatada possam a vir ocorrer em outras unidades da federação.

20. Por fim, entende-se que os fatos narrados apresentam alta relevância, especialmente por se tratarem de recursos públicos destinados ao Combate do Covid-19, e se não forem adotadas medidas emergenciais diante da crise gerada com a falta de oxigênio medicinal, poderá colocar em risco vidas humanas e tornar sem efeito ações e gastos governamentais.

21. Caracterizados como altos a materialidade, o risco e a relevância, é o caso de dar prosseguimento ao processo, com base no art. 106, § 3º, II da Resolução-TCU 259/2014.

EXAME TÉCNICO

Resposta da Ebserh (peças 39-72)

15. Por meio do Ofício SEI 84/2021/PRES-EBSERH, de 19/3/2021, o Presidente da Ebserh apresentou a Nota Técnica - SEI 2/2021/CGR/VP-EBSERH, e anexos, de lavra das áreas técnicas da empresa, Diretoria da Vice-Presidência, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde e Diretoria de Administração e Infraestrutura, para responder a diligência.

Ocorrência: Item b.1) informações se o HUGV estava com estrutura preparada, em termos de recursos humanos e insumos necessários, para abertura de 17 (dezessete) leitos de enfermaria e 10 (dez) leitos de UTI, em 30/12/2020, para pacientes de Covid-19, uma vez que havia orientação da direção central para abertura de 10 leitos de UTI, e o hospital não era mais referência para essa doença desde 30/7/2020*.*

16. A Ebserh informou que:

16.1. No mês de outubro de 2020, com o início da segunda onda da pandemia na Europa e o crescimento rápido do número de casos e aumento de internações, o Comitê de Operações de Emergência (COE) da Ebserh, com a finalidade de monitorar a capacidade de uma nova mobilização de recursos para reabertura de leitos para atendimento a pacientes com Covid-19, solicitou aos hospitais localizados nos estados que tiveram picos de casos Covid-19 registrados entre abril e junho de 2020 a revisão dos planos de contingência locais, conforme Ofício Circular SEI 1/2020/CGC/DEPAS-Ebserh (peça 53).

16.2. A inserção do hospital no enfrentamento da pandemia foi guiada pelas demandas do gestor local e a revisão do plano de contingência observou a pactuação feita com a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM).

16.3. No mês de novembro, o Plano de Contingência do HUGV-Ufam foi atualizado e serviu de guia para a estruturação do hospital para os cenários de acionamento. Nesse sentido, houve o incremento dos insumos e da força de trabalho, de modo a viabilizar a abertura dos leitos pactuados, estando o hospital apto para atender a demanda.

Ocorrência: Item b.2) os estudos de viabilidade para atendimento dessa demanda, em termos de profissionais, equipamentos, medicamentos e insumos médico-hospitalares, especialmente oxigênio medicinal, se houver*.*

17. A Ebserh informou que:

17.1. O plano de contingência é o estudo que considera a demanda e as condições essenciais ao aumento da capacidade de atendimento à Covid-19, evidenciando as necessidades de profissionais, equipamentos, medicamentos e insumos.

17.2. Durante o curso da pandemia, para atender as demandas do gestor local de saúde, os planos sofreram modificações, apresentando novos cenários de atuação (peças 46-48 e 55).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

17.3. Em relação ao oxigênio medicinal, o HUGV encontrava-se abastecido, utilizando o saldo da Ata de Registro de Preços/Contrato vigente, por meio do qual foram contratados 100.648 m³/ano e havia saldo disponível de 84.148 m³ para consumo em 2021.

Ocorrência: Item b.3) informações sobre a cessão de dois andares do HUGV, em janeiro de 2021, para Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas para abertura de 108 (cento e oito) leitos de enfermaria e mais 10 (dez) leitos de UTI para pacientes de Covid-19, indicando com os documentos comprobatórios.

18. A Ebserh informou que:

18.1. Colocou todo o seu plano de contingência em ação para o gestor local, mas o quantitativo de leitos não foi suficiente para atender à demanda. Diante deste cenário, o Governador do Estado do Amazonas visitou a Administração Central da Ebserh, em 6/1/2021, solicitando apoio no sentido de que fosse disponibilizada estrutura física da torre B do HUGV-Ufam para utilização pela SES-AM.

18.2. A avaliação presencial feita pelos técnicos da SES-AM apontou ser inviável a utilização da torre B, optando-se por utilizar os 6° e 7° andares da torre A como Hospital de Campanha do Estado, totalizando 108 (cento e oito) leitos de enfermaria.

18.3. No item 4.1 do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) do mês de janeiro de 2021 (peça 55), consta que foram disponibilizados leitos Covid nos andares 6º e 7º para Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.

18.4. Apesar de inicialmente terem sido planejados 108 leitos, 54 em cada andar, após a avaliação feita pela equipe do hospital acerca da estrutura disponível, foi viável disponibilizar à SES-AM 48 leitos no 6° andar e, num segundo momento, 48 leitos do 7° andar, conforme descrito no nível 4 do item 4.1 do Plano de Contingência (12 leitos a menos que o planejado).

Ocorrência: Item b.3.1) mantenedor desses leitos em termos de recursos financeiros, profissionais e insumos médico-hospitalares (Ebserh ou governo do estado).

19. A Ebserh informou que:

19.1. Ao longo das tratativas para a disponibilização dessa estrutura, conforme ata de reunião de 13/1/2021 (peça 50), o Secretário de Atenção Especializada à Saúde – SAES/MS assumiu a responsabilidade, em nome do Ministério da Saúde, acerca do provimento de materiais, equipamentos e pessoal.

19.2. Na mesma reunião ficou registrado que seria dada prioridade à resposta quanto aos itens ventilação e oxigênio.

19.3. A solicitação de apoio, por parte da SES-AM, foi formalizada, posteriormente, ao Ministério da Saúde e à Ebserh por meio do Ofício 647/2021 - GAB/SES-AM, datado de 30/1/2021 (peça 54), o qual informa que o órgão estadual de saúde já teria disponibilizado ao HUGV-Ufam equipe médica e de enfermagem, materiais e equipamentos suficientes para atender aos leitos, medicamentos e produtos para saúde, atendidas as listas solicitadas.

19.4. A realidade mostrou-se distante daquilo que foi registrado na ata de reunião e no ofício mencionado, uma vez que o Ministério da Saúde e a SES-AM não têm conseguido suprir o hospital para viabilizar o atendimento desses leitos, gerando o consumo dos insumos que foram adquiridos para atender aos leitos pactuados no Plano de Contingência do HUGV-Ufam.

19.5. As listas de medicamentos e produtos para a saúde não têm sido atendidas pela SES-AM, colocando em risco o abastecimento adequado para manter os leitos da SES-AM. Também se mostrou insuficiente a força de trabalho efetivamente alocada, tendo em vista que parte dos profissionais foram remanejados para outros hospitais.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

19.6. Precisou articular-se internamente para realocar insumos entre as unidades da rede, conforme evidenciado em Ofício - SEI 12 (peça 49) e Ofício - SEI 46 (peça 51) e contratar profissionais para atendimento aos leitos que seriam de responsabilidade da SES-AM e não foi possível disponibilizar a totalidade dos leitos de forma imediata.

19.7. A situação de abastecimento tem sido avaliada diariamente para dimensionar o quantitativo de leitos que podem ser atendidos.

19.8. A responsabilidade sobre a manutenção desses leitos deveria estar compartilhada entre o Ministério da Saúde e a SES-AM.

Ocorrência: Item b.3.2) se todos esses leitos foram ocupados no mês de janeiro e se ainda persiste a cessão, bem como a sua ocupação atual.

20. A Ebserh informou que:

20.1. A ocupação dos leitos obedeceu à capacidade de atendimento, observando a disponibilidade de insumos e equipe e o indicador de ocupação dos leitos hospitalares clínicos e de UTI Covid-19 foi de 74,6 no mês de janeiro (peça 72).

20.2. Atualmente a cessão persiste e a ocupação dos leitos hospitalares e o indicador de ocupação dos leitos hospitalares clínicos e de UTI Covid-19, no período de 1º a 15/3/2021, foi de 88,2 (peça 71).

Ocorrência: Item b.3.3) se foi previsto no contrato com a White Martins esse aumento de pacientes, uma vez que afetaria o consumo de oxigênio ou esse consumo seria fornecido pela secretaria de saúde.

21. A Ebserh informou que:

21.1. O fornecimento de oxigênio pela White Martins decorre da Ata de Registro de Preços – ARP (peça 52), com formalização dos contratos por meio de nota de empenho e assinatura de contrato de comodato referente ao tanque criogênico, firmado em agosto do ano de 2020 (peça 56) em momento anterior ao cenário de colapso do estado do Amazonas.

21.2. A contratação em questão considerou uma majoração do consumo em relação ao ano de 2019, conforme explanado em resposta à diligência inicial, considerando também o plano de contingência do hospital vigente à época, sendo a contratação por fornecimento ininterrupto, conforme cláusulas do Termo de Referência (peça 57) transcritas a seguir:

> *"Cláusula 1.5 O fornecimento dos gases medicinais deverá obedecer ao cronograma, aos procedimentos e aos horários estabelecidos pelo HUGV, assegurando o fornecimento ininterrupto dos gases medicinais;"*
>
> *"Cláusula 1.11 Compete à CONTRATADA, para o fornecimento de gases medicinais criogênicos, instalação e manutenção dos tanques estacionários criogênicos, vaporizadores e acessórios nos locais indicados pelo HUGV e suas interligações às redes existentes no local."*
>
> *"Cláusula 10.20 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação".*

21.3. O volume constante da ARP é de 100.648 m^3/ano, e o total empenhado entre 25/8/2020, data de assinatura do contrato, e 31/12/2020 foi de 16.500 m^3, restando, portanto, um saldo de 84.148 m^3 de oxigênio disponíveis para consumo em 2021.

21.4. Em 2020, foram consumidos 45.554 m^3 de oxigênio, com média diária de 124,8 m^3. Em janeiro de 2021, foram consumidos 14.221 m^3, 31,22% do que foi consumido em 2020 inteiro, perfazendo a média diária de 458,74 m^3, com oscilações de 20 a 61 m^3/h.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

21.5. O detalhamento do consumo consta de planilha anexa (peça 58) e ainda que o consumo do momento de crise perdurasse no tempo, o volume contratado seria suficiente para o pleno funcionamento do hospital por aproximadamente 6 meses, prazo previsto para encerramento da vigência da ARP e consequente realização de nova contratação.

21.6. Caso fosse atingido o volume total contratado, ainda seria possível a realização de termo aditivo para acréscimo quantitativo de até 25%, o que traz ainda maior segurança ao hospital. Assim, não houve interrupção de fornecimento decorrente de possível ausência de saldo contratual, motivo pelo qual resta afastada eventual falta de planejamento para fornecimento de oxigênio para os pacientes do hospital.

Ocorrência: Item b.3.4) se foi celebrado o contrato de cessão desses andares.

22. A Ebserh informou que o termo de cessão foi elaborado e apresentado, entretanto, conforme ata de reunião de 13/1/2021 (peça 50), o Sr. Luiz Otávio Franco Duarte disse não haver necessidade de assinar o referido documento.

Ocorrência: Item b.4) informações com quantitativo diário de pacientes com Covid-19 internados, clínicos e UTI, no período de 1°/1/2021 a 31/1/2021, bem como de pacientes falecidos nesse período.

23. A Ebserh apresentou dados quantitativos diários de pacientes: UTI, enfermaria e óbitos, referentes ao período de 1°/12/2020 a 31/1/2021 (peça 70), ratificados pelo Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde.

Ocorrência: Item b.5) o processo do Pregão Eletrônico 22/2020, de agosto/2020, com o seu termo de referência e estudos preliminares.

24. A Ebserh encaminhou o termo de referência e os estudos preliminares (peça 57).

Ocorrência: Item b.5.1) esclareça se o volume homologado de 100.648 m³ de oxigênio medicinal contratado junto a White Martins, era para fornecimento ao HUGV anual, mensal ou diário, pois não foi informado na resposta de diligência anterior.

25. A Ebserh informou que o volume homologado de 100.648 m³ de oxigênio medicinal criogênico era para fornecimento anual (12 meses), conforme contrato de comodato (peça 56).

Ocorrência: Item b.5.2) informe o histórico de consumo diário de oxigênio do HUGV, em 2020, e no período de janeiro de 2021.

26. A Ebserh informou que, em 2020, foram consumidos 45.554 m³, com média diária de 124,8 m³. Em janeiro de 2021, foram consumidos 14.221 m³, representando 31,22% do que foi consumido no ano de 2020, perfazendo média diária de 458,74 m³, com oscilações de 20 a 61 m³/h. O detalhamento do consumo consta da planilha de peça 56.

Ocorrência: Item b.5.3) informe como é feito o pagamento do oxigênio medicinal, se por quantidade e valor fixo ou se por demanda, com valor variável pelo seu consumo, ou outra forma acertada, bem como qual tipo de controle é realizado pelo hospital para aferir o quantitativo consumido e faturado

27. A Ebserh informou que:

27.1. O pagamento de oxigênio medicinal é feito por demanda de consumo no mês. O valor unitário é o registrado na Ata de registro de Preços junto com a empresa vencedora e o HUGV-Ufam (peça 52).

27.2. A necessidade do hospital é solicitada de acordo com a demanda, através da central de relacionamento com o cliente da empresa White Martins (0800 709 9000) e a entrega é feita na instituição, no prazo máximo de 24h para todos os itens, à exceção do tanque criogênico que é controlado via telemetria pela fornecedora, que deve abastecer imediatamente quando o tanque atingir de 30 a 40% de sua capacidade.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

27.3. No ato do recebimento e/ou abastecimento, o colaborador do hospital realiza a conferência, recebe o gás e assina o comprovante de recebimento que gerará a nota fiscal da empresa. Mensalmente, a empresa entrega um processo físico no HUGV, com a nota fiscal, comprovantes de recebimento e demais documentações. A documentação é conferida pelos fiscais do contrato e encaminhada para pagamento.

27.4. O controle do hospital para a quantidade consumida e faturada é realizado por meio da conferência das notas fiscais e comprovantes entregues na instituição pela empresa e o abastecimento do oxigênio é realizado por demanda com valor variável pelo seu consumo.

Ocorrência: Item b.5.4) informe se a empresa White Martins atendeu com fornecimento de oxigênio medicinal, de acordo com a demanda contratada. Em caso negativo, quais as providências adotadas?

28. A Ebserh informou que:

28.1. A empresa White Martins atendeu toda a demanda do HUGV durante todos os períodos do contrato, à exceção do episódio já relatado de janeiro de 2021, quando não houve nenhuma notificação, aviso ou comunicação da interrupção de abastecimento, em desacordo com o expresso no contrato.

28.2. Nos dias 14 e 15 de janeiro, o HUGV tentou contato telefônico, de forma incessante e sem sucesso, com a empresa e representantes do hospital se dirigiram à White Martins para obter informações, também sem êxito.

28.3. Ninguém da empresa atendeu ao hospital até o final da tarde do dia 15 de janeiro, quando houve a visita do Diretor Executivo nacional da White Martins, sendo registrado o teor da reunião em ata (peça 59).

28.4. Em razão do desabastecimento de oxigênio medicinal, foi gerado um relato de ocorrência e a empresa foi notificada (peça 59), sendo realizada ainda ocorrência junto à Polícia Federal, conforme consta na Certidão de Ocorrência, de 22/1/2021 (peça 69).

28.5. Foi aberto processo emergencial para nova contratação por prazo de 180 (cento e oitenta) dias (peça 62).

28.6. Após o ocorrido, encaminhou o Ofício - SEI 111/2021/DLIH/GA/HUGV-UFAM-EBSERH (peça 61), que dispõe das informações acerca da substituição do tanque estacionário de oxigênio líquido, da empresa White Martins, de capacidade de 4.900 m³, por um novo tanque com capacidade de 9.800 m³, disponível por meio de comodato para atender o hospital.

28.7. Tratativas complementares culminaram na instalação de Usina de O_2, tipo PSA (Pressure Swing Adsorption), com capacidade de 30 m³/h, que resultou em capacidade suficiente para suprir a demanda de oxigênio hospitalar e que, a partir do dia 16/1/2021, o abastecimento foi normalizado.

Ocorrência: Item b.6) informações de transferência de pacientes com Covid-19 para outros hospitais da rede Ebserh indicando: Item b.6.1) se esses pacientes seriam referenciados do HUGV ou de outras unidades da rede estadual de saúde;

29. A Ebserh informou que:

29.1. Esta ação foi liderada pelo Ministério da Saúde, que pediu apoio para acolher pacientes deslocados do estado do Amazonas, conforme Ofício 118/2021/SE/GAB/SE/MS (peça 60).

29.2. Os pacientes acolhidos foram exclusivamente de outras unidades da rede de saúde e, no primeiro momento, competiu à estatal somente a disponibilização dos leitos nas unidades da federação que estivessem acima da linha Goiânia e Brasília.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

29.3. No sentido de organizar o processo de transferência de pacientes do HUGV-Ufam para outras unidades, considerando os fluxos internos de recebimento, foi publicada a Nota Técnica - SEI 1/2021/SGQ/CGC/DEPAS-EBSERH (peça 64), que versa sobre a operacionalização da admissão e o manejo clínico de pacientes Covid-19 transferidos para a rede Ebserh.

29.4. Como forma também de trazer maior segurança aos Hospitais da Rede Ebserh, foi disponibilizado o Checklist de Admissão Segura de Pacientes Covid-19 transferidos de outras Unidades Hospitalares (peça 65).

29.5. Todo o processo de elegibilidade tanto da unidade de origem do paciente quanto das suas condições clínicas para o transporte aeromédico para realizar tratamento em outra localidade, assim como a disponibilidade do transporte aéreo, foram de responsabilidade do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas.

Ocorrência: Item b.6.2) se existe estudo que avalie se o quantitativo de pacientes com Covid-19 transferidos não venha sobrecarregar a unidade hospitalar recebedora;

30. A Ebserh informou que:

30.1. Tendo em vista o momento crítico da situação de saúde do estado do Amazonas e a premente necessidade de evacuação de pacientes devido ao colapso da rede de saúde local, não houve tempo hábil para realizar um estudo aprofundado como a situação mereceria, uma vez que era presente o risco de morte dos pacientes.

30.2. Não competia à Ebserh, como empresa vinculada ao MEC, realizar esses estudos para regulação de pacientes para atendimento interestadual.

30.3. Competiu tão somente a oferta de leitos, ficando a cargo do Ministério da Saúde a decisão sobre a ocupação em articulação com os entes federados e que a demanda foi encaminhada pelo Ministro da Saúde ao Presidente da Ebserh à 01h da manhã do dia 14/1/2021, fato já informado ao Ministério Público Federal em Manaus.

30.4. Para atender ao Ministério da Saúde, os Superintendentes dos Hospitais Universitários da Rede Ebserh foram consultados sobre a possibilidade e a viabilidade de receber emergencialmente os pacientes de Manaus, levando em consideração a estrutura que poderiam ofertar no curso da pandemia e que não estivesse comprometida com o gestor de saúde local.

30.5. A prioridade dos hospitais era o atendimento das necessidades de sua rede de atenção e, por esta razão, o quantitativo de leitos sofreu revisões, de acordo com o cenário local de cada unidade, inclusive com orientação de consulta ao gestor acerca da disponibilização dos leitos (peça 63).

30.6. Foram feitas revisões dos quantitativos de leitos conforme documentos de peças 66-68 e não houve sobrecarga das unidades recebedoras ao longo da ação. Cabe ressaltar que a operação estabelecida pelo Ministério da Saúde foi realizada em comum e prévio acordo com as unidades da federação envolvidas.

30.7. A operacionalização dos meios empregados contou com o apoio de ambulâncias disponibilizadas pelos estados e municípios para o deslocamento do aeroporto até o hospital universitário, tudo coordenado diretamente pelo Ministério da Saúde e unidades federativas.

30.8. O retorno dos pacientes para Manaus ficou a cargo dos Superintendentes do Ministério da Saúde nos estados, com o concurso de recurso financeiro do Amazonas.

31. A empresa finaliza informando que, desde o início da instalação da situação de ESPIN, a Rede Ebserh, tanto a Administração Central como, e principalmente, suas 40 unidades hospitalares, têm atuado de maneira permanente no sentido de oferecer o devido apoio à sociedade brasileira no atual contexto preocupante da pandemia e que foram disponibilizados: 1.040 leitos de enfermaria

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

adulto, 129 leitos de enfermaria obstétrica, 107 leitos de enfermaria pediátrica, 654 leitos de UTI adulto, 37 leitos de UTI pediátrica e 73 leitos de UTI neonatal, perfazendo um total de 2.040 leitos, dos quais 77,3% encontram-se ocupados.

Análise das respostas da Ebserh

32. A finalidade da nova diligência realizada à Ebserh teve por pressuposto obter informações para sanear o processo acerca da falta de oxigênio medicinal na unidade da empresa localizada em Manaus.

32.1. Analisando-se as respostas e os documentos apresentados, verifica-se que a empresa se inseriu no enfrentamento à Covid-19 atendendo às expectativas acordadas com o gestor da SES-AM, alterando seu plano de contingência para se adequar às necessidades de assistência à saúde requeridas.

32.2. Nesse sentido, o hospital, em dezembro de 2020, estava se adequando para receber mais pacientes referenciados pelo gestor de saúde estadual (mais 17 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI), conforme peça 45.

32.3. Antes de ocorrer o colapso de desabastecimento, a empresa foi procurada pelo governador do estado para ceder a torre B do hospital, com planejamento de abertura de 108 leitos, sendo posteriormente alterada a demanda para cessão de dois andares (torre A) para a SES-AM.

32.4. Os recursos humanos, financeiros e materiais para manutenção dos leitos dos andares cedidos seriam de responsabilidade do Ministério da Saúde e da SES-AM, todavia o custeio efetivo foi realizado pela empresa com os insumos estabelecidos de seu plano de contingência. No processo de pactuação entre Ministério da Saúde, Ebserh e SES-AM, essas questões devem ser solucionadas entre as partes envolvidas, considerando a situação de emergência que o estado do Amazonas, em especial a capital Manaus, apresentava no mês de janeiro de 2021, com incremento exponencial de casos de Covid-19, levando a acelerado aumento na busca de leitos e de consumo de medicamentos e insumos, inclusive oxigênio medicinal (peças 49-51, 54 e 66-68).

32.5. Em relação à transferência de pacientes de Manaus para outras unidades da Ebserh no território nacional, a medida foi considerada solução viável no cenário de falta de leitos e de limitação de insumos, especificamente de oxigênio medicinal, e medicamentos para atendimento na busca de salvar o maior número de vidas.

32.6. A empresa buscou informações em suas unidades em outras unidades da federação acerca da possibilidade de acolher pacientes de Manaus, sem comprometer a sua estrutura de atendimento, e os hospitais onde havia espaço passaram a receber os pacientes referenciados e prestar a assistência necessária, como apoio das secretarias estaduais de saúde, das Forças Armadas e do Ministério da Saúde.

32.7. Todos os órgãos e entidades envolvidos na operação atuaram de forma coordenada e utilizaram a transferência de pacientes como um dos meios para mitigar os efeitos do colapso do sistema de saúde do governo do estado do Amazonas naquela ocasião (peças 60 e 63-65).

32.8. Por outro lado, o problema suscitado nesta representação em relação à Ebserh envolve a falta de abastecimento de oxigênio no dia 14 de janeiro de 2021.

32.9. A empresa informou que estava preparada para o incremento de leitos, mesmo os decorrentes da cessão, tendo por base a quantidade de oxigênio contratada junto à fornecedora White Martins, considerando o volume contratado em 2020 de 100.648 m^3/ano.

32.10. O consumo, em 2020, foi de 45.554 m^3, com média diária de 124,8 m^3, restando para 2021 o quantitativo de 55.094 m^3. Em janeiro de 2021, foram consumidos 14.221 m^3, representando 31,22%

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

do que foi consumido no ano de 2020, conforme Tabela 1 – Consumo de Oxigênio Medicinal 2020 (peça 58):

Tabela 1 - Consumo de Oxigênio Medicinal 2020

Meses	***Consumo (m^3)***
Janeiro	*5.040*
Fevereiro	*2.337*
Março	*6.073*
Abril	*2.480*
Maio	*6.737*
Julho [1]	*4.720*
Agosto	*3.175*
Setembro	*2.179*
Outubro	*3.357*
Novembro	*6.576*
Dezembro	*2.880*
Total	***45.554***

Fonte:*Ebserh (adaptado) peça 58.*

Nota 1: Não consta dados de junho/2020

32.11. O documento de contato do HUGV com a White Martins, de 13/1/2021, informa que o tanque de oxigênio criogênico não tinha sido abastecido desde o dia 9 de janeiro, apesar de ter sido solicitado à empresa e que o hospital estava sendo mantido com a bateria de cilindros de reserva, os quais eram trocados a cada 3 horas (peça 59).

32.12. A empresa não atendeu o fornecimento contratado, deixando o hospital sem abastecimento no dia 14 de janeiro, não informou medidas para solucionar o problema e ainda não atendeu os representantes do hospital, seja por via telefônica, seja no atendimento presencial.

32.13. Somente no dia 15 de janeiro, a direção central da empresa buscou o hospital na tentativa de apresentar soluções para restabelecer o fornecimento, o qual estava sendo mantido por familiares de pacientes internados, por profissionais de saúde e doações de pessoas físicas e empresas.

32.14. A partir dessa reunião, a empresa White Martins instalou usina de O_2, tipo PSA (Pressure Swing Adsorption), ou processo de adsorção, com capacidade de fornecimento de oxigênio de 30 m^3/h, sendo restabelecido no dia 16 de janeiro o fluxo contínuo de oxigênio.

32.15. A empresa, desde o dia 7 de janeiro, já havia comunicado a SES-AM a dificuldade de manter o sistema de fornecimento em atendimento (peça 81), com o aumento da demanda nos dias

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

iniciais de janeiro, e consequentemente poderia ter adotado medidas juntamente com a direção do HUGV para mitigar a situação, uma vez que não abasteceu o tanque de oxigênio criogênico e manteve o fornecimento com cilindros (bateria de reserva).

32.16. As dificuldades logísticas da cidade de Manaus para seu abastecimento, que depende de suprimento vindo de outros pontos do território nacional, deveriam ter sido consideradas, uma vez que, pelo transporte rodofluvial, a depender de onde a carga for embarcada, o suprimento pode demorar período superior a cinco dias. Outra alternativa para realizar o suprimento é o transporte aéreo, o qual apresenta limitações em relação ao volume transportado e às condições de segurança de voo em transportar altos volumes de oxigênio em cilindros. Também há a possibilidade de instalação de usina de oxigênio, que se mostrou medida eficiente e rápida para restabelecer o fluxo contínuo desse produto no HUGV, dependendo do volume demandado pela unidade de saúde.

32.17. Ressalte-se que, apesar do aumento do consumo de oxigênio no mês de janeiro (14.221 m^3), havia tempo suficiente para atender a essa demanda se a empresa tivesse abastecido o tanque de oxigênio criogênico ou buscado alternativas, isolada ou conjuntamente com a Ebserh. A inércia da empresa em oferecer uma solução pode ter sido uma das causas das perdas de cinco vidas humanas ocorridas nos dias 14 e 15 de janeiro, as quais poderiam ter tido desfecho melhor se não tivesse ocorrido a situação de falta de oxigênio (peça 70).

32.18. Verifica-se ainda que a direção local da Ebserh confiou na capacidade de atendimento da empresa White Martins em razão de possuir quantitativo de oxigênio medicinal suficiente para atender a demanda, mesmo na excepcionalidade daquele momento, e pela inadimplência da empresa e falta de contato, realizou boletim de ocorrência na Polícia Federal.

32.19. A Ebserh informou que instaurou procedimento acerca da falta de fornecimento de oxigênio. Essa providência, no campo administrativo, encontra amparo legal nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pelo descumprimento parcial do contrato e pode ensejar a aplicação de sanções para a contratada. Nos dias 1º e 2/12/2021, em contato telefônico com o responsável pela auditoria interna da Ebserh do Hospital Getúlio Vargas, em Manaus, para se conhecer o resultado do processo, não se obteve resposta acerca da conclusão do procedimento, cabendo proposta de determinação para apresentação do processo de apuração de possível descumprimento contratual da empresa White Martins no abastecimento de oxigênio medicinal.

32.20. Destaca-se que o HUGV adotou medidas de controle do fluxo de oxigênio, pois acompanhou e informou o não abastecimento do tanque, bem como colocou um agente de segurança para monitorar o fornecimento via cilindros, a fim de se fazer as substituições no momento que estavam esvaziados, e havia um processo de acompanhamento desde o abastecimento até o pagamento das faturas.

32.21. Não se pode deixar de levar em consideração que o oxigênio fornecido para o HUGV advinha da mesma planta industrial da empresa White Martins em Manaus e, como é de conhecimento, estava sobrecarregada pela alta demanda da cidade de Manaus, que acabou se difundindo por outros municípios em decorrência das dificuldades de abastecimento dessa cadeia logística.

32.22. Ainda, a empresa realizou novo processo de aquisição de oxigênio medicinal e substituiu o tanque de oxigênio criogênico por outro com o dobro de sua capacidade, em contrato de comodato com a referida empresa, tudo isso para procurar atender ao fluxo crescente de demanda por leitos decorrente do novo coronavírus (peça 61).

32.23. Dessa forma, considerando os elementos trazidos aos autos, entende-se que a Ebserh, por meio de seus dirigentes e demais empregados, adotou as medidas disponíveis para atendimento dos pacientes internados e para mitigar a falta de abastecimento de oxigênio medicinal ocorrida no dia 14 de janeiro de 2021, tais como solicitando da empresa o abastecimento do tanque de oxigênio

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

criogênico, buscando uma solução imediata quando esse item faltou, ampliando o reservatório, instalando usina de oxigênio e realizando novo procedimento de contratação. Portanto, não se vislumbra a presença de dolo ou erro grosseiro, nos termos do art. 28 do Decreto-Lei 4.657/1942, para imputação de responsabilidades aos agentes públicas da referida empresa.

32.24. Diante do exposto, propõe-se:

I - com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh que, no prazo de quinze dias, apresente ao Tribunal o resultado do processo de apuração de descumprimento parcial de contrato pela empresa White Martins, pela falta de fornecimento contínuo de oxigênio, em janeiro de 2021, no HUGV/Ebserh.

II – encaminhar a decisão adotada pelo Tribunal e desta instrução à Procuradoria da República no estado do Amazonas, diante da perda de cinco pacientes nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, no período de desabastecimento de oxigênio, para conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes.

Resposta do Ministério da Saúde (peça 80)

33. Por meio do Ofício 439/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, de 3/5/2021, a Coordenadora-geral de Controle Interno do Ministério da Saúde encaminhou o Despacho SE/GAB/SE/MS (SEI 0019600122) e o Despacho SAES/NUJUR/SAES/MS (SEI 0020007071).

Ocorrência: a.1) informações da existência ou da elaboração de plano de contingência nacional para enfrentamento de situações de excesso de demanda de leitos para Covid-19, nos estados brasileiros, para que não haja falta de atendimento de pacientes, seja pela ausência de estrutura física, por falta de profissionais ou falta de insumos médico-hospitalares, como ocorreu com a falta de oxigênio medicinal em Manaus/AM e Faro/PA, em janeiro de 2021*;*

34. Em Despacho firmado em 30/4/2021, o Secretário de Atenção Especializada à Saúde ratificou e encaminhou o despacho assinado pelo Coordenador-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar e pelo Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência substituto, datado de 12/4/2021, informando que:

34.1. O Ministério da Saúde, desde o início do ano de 2020, vem empreendendo esforços para auxiliar técnica e financeiramente os estados e municípios por meio no atendimento de seus planos de contingência, sobretudo acompanhando os processos de estruturação dos estabelecimentos hospitalares para atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19.

34.2 A Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar é o ponto de apoio e a área responsável pelo registro de solicitações de habilitações de leitos de UTI Covid-19, de leitos de suporte ventilatório, autorização de funcionamento de leitos de Unidade de Cuidados Prolongados em Hospitais de Pequeno Porte, bem como pela demanda e distribuição de respiradores.

34.3 Desde o início do mês de janeiro do corrente ano, está presente no estado do Amazonas trabalhando em conjunto com os gestores locais para mapear e apoiar as ações de enfrentamento aos efeitos provocados pelo segundo ciclo da epidemia na região.

34.4. Dentre as ações conduzidas no Amazonas com suporte técnico da equipe do Ministério da Saúde, tem-se as transferências de pacientes para outros estados, abertura de chamamento público para contratação de recursos humanos, ampliação da rede para regulação de pacientes acometidos pela Covid-19, entrega de doses da vacina, recrutamento de médicos do Programa Mais Médicos visando fortalecer o contingente de profissionais.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

34.5. O planejamento, a organização e execução das ações e serviços de saúde ficam sob a responsabilidade originária da gestão em âmbito local, no caso os gestores municipais, e subsidiariamente aos estados.

34.6. Cabe aos gestores estaduais a interlocução com o Ministério da Saúde, via planos de contingência, trazendo ao conhecimento deste as carências e as necessidades dos municípios componentes de seu território, a fim de que se possa consubstanciar as tomadas de decisão conjuntas e viabilizar o apoio técnico e financeiro e neste contexto inserem-se os processos de credenciamento dos leitos de UTI, os quais deverão ser solicitados por intermédio do SAIPS - Sistema de Apoio a Implementação de Políticas de Saúde.

34.7. Foram abertos no estado do Amazonas novos leitos de UTI Covid-19 pela Portaria GM/MS 373, de 2/3/2021 (50 leitos, com valor de custeio de R$ 2.400.000,00); Portaria GM/MS 431, de 11/3/2021 (92 leitos, com valor de custeio de R$ 4.416.000,00); Portaria GM/MS 518 de 23/3/2021 (30 leitos, com valor de custeio de R$ 1.440.000,00); e Portaria GM/MS 558 de 26/3/2021 (45 leitos, com valor de custeio de R$ 2.160.000,00).

34.8. Desde o início da pandemia até a presente data, foram habilitados um total de 463 leitos na tipologia Adulto e 13 leitos na tipologia Pediátrico Covid-19, contabilizando o valor de custeio total de R$ 45.840.000,00, além de 20 kits UTI para o estado do Amazonas. Em adição, foram distribuídos 650 ventiladores pulmonares e 315 monitores multiparâmetros.

34.9. O estado do Amazonas recebeu recursos financeiros por meio da Portaria GM/MS 3.896/2020, no valor total de R$ 25.490.722,37, destinados ao cumprimento das demandas assistenciais geradas pelo Coronavírus, preferencialmente destinados ao custeio de leitos de UTI Covid-19 e leitos de suporte ventilatório pulmonar.

34.10. A missão contou com a participação ativa do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência no encaminhamento de colaboradores até meados de fevereiro de 2021, na fase crítica, para a realização de diagnóstico da situação local e apoiar tecnicamente nos processos de gestão com vistas à redução dos danos sofridos pela população do estado.

34.11. As solicitações dos gestores vêm sendo analisadas ininterruptamente, com a máxima efetividade e empenho.

Ocorrência: a.2) o ofício do governo do estado do Amazonas solicitando a suspensão do apoio para transporte de cilindros de oxigênio para Manaus, em janeiro de 2021, como informado no Despacho SE/GAB/SE/MS, de 3/2/2021.

35. A Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva substituta, em Despacho datado de 17/3/2021, informou que:

> *no tocante ao quesito "a.2" cabe informar que esta SE tem conhecimento informal acerca da expedição de ofício pelo governo do estado do Amazonas dirigido ao Ministério da Defesa acerca da matéria, razão pela qual entende-se deva ser aquela Pasta Ministerial demandada à apresentação do documento em questão.*

Análise das respostas do Ministério da Saúde

36. A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, incumbida pela Secretaria Executiva, não informou da existência de plano de contingência nacional para enfrentamento de situações de excesso de demanda de leitos para Covid-19, nos estados brasileiros, para que não ocorra falta de atendimento de pacientes, seja pela ausência de estrutura física, por falta de profissionais ou falta de insumos médico-hospitalares, limitando-se a prestar informações já oferecidas pelo órgão na primeira diligência realizada em janeiro de 2021 (peças 7 e 19).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

36.1. O Ministério da Saúde realiza transferência de recursos para os entes subnacionais, seja por meio das transferências fundo a fundo, seja por meio do envio de vacinas, insumos, medicamentos, respiradores, dentre outros itens, conforme pode ser verificado nos painéis dispostos no portal LocalizaSUS (disponível em https://www.localizasus.com/p/index.html).

36.2. Todavia, em relação aos instrumentos utilizados para controlar a destinação dos recursos transferidos aos entes subnacionais, para prever e ter controle sobre o abastecimento de insumos e medicamentos críticos e comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais, o Ministério da Saúde informou que o controle originário é do ente recebedor, que disponibilizou o sistema Siops com campo gerencial próprio para os gastos com Covid-19, que foi criada a plataforma LocalizaSUS, e que a transparência dos recursos transferidos consta no Portal do Fundo Nacional de Saúde, na opção para gastos com Covid-19 (http://www.portalfns.saude.gov.br), consulta de pagamentos detalhada, nos blocos custeio e investimento, grupo Coronavírus – Covid-19) – peça 19.

36.3. Esses sistemas apresentam relação direta com o controle orçamentário e financeiro dos recursos transferidos, mas diante da crise de desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus no mês de janeiro, fica muito evidente que o órgão central de saúde não possuía informações suficientes e tempestivas sobre o abastecimento de insumos e medicamentos críticos e sua regular aplicação de recursos.

36.4. Na crise do oxigênio em Manaus, o Ministério da Saúde teve um papel reativo, buscando mitigar, quando informado pelo governo do estado do Amazonas, soluções junto ao Ministério da Defesa para transporte de cilindros de oxigênio de outros pontos do território nacional, bem como da Ebserh, para transferência e acolhimento de pacientes.

36.5. O estado do Amazonas alega que solicitou apoio logístico para transporte de cilindros de oxigênio no dia 7 de janeiro (peça 81); já o Ministério da Saúde, na resposta da diligência inicial, indica a data do dia 8 do citado mês (peça 19). De qualquer maneira, agiu somente depois de demandado.

36.6. A situação de elevação de casos e tendência de aumento de leitos era de conhecimento do governo estadual, o qual adotou medidas como fechamento do comércio no dia 26 de dezembro de 2020, reabrindo no dia 28 do mesmo mês diante de manifestações feitas na cidade. Tudo indica que naquele momento (dezembro de 2020), o ente subnacional deveria ter informado a problemática e solicitado apoio do Ministério da Saúde, e por sua vez, a pasta ministerial deveria também exercer o seu papel de coordenação para monitorar os itens estratégicos, com informações de qualidade sobre a real situação dos entes subnacionais.

36.7. Tais medidas de acompanhamento e controle não foram tomadas tempestivamente e o desfecho foi o colapso do sistema no mês de janeiro de 2021, ocasião em que o Ministério da Saúde buscou mitigar a situação para evitar dano maior com o envolvimento de outros órgãos e entidades públicas federais, como o Ministério da Defesa e a Ebserh.

36.8. A contratação, distribuição e consumo do oxigênio medicinal compete aos entes subnacionais, os quais devem fazer as aquisições de acordo com a demanda para suas unidades hospitalares e demais unidades de saúde que utilizem esse produto, nos termos do art. 17, incisos I, II, III, IV, alínea "a", VIII e IX, da Lei 8.080/1990, sem prejuízo das pactuações realizadas no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), conforme art. 14-A da citada lei.

36.9. O papel do Ministério da Saúde é fomentar as políticas públicas de saúde como órgão central, estando essas competências relacionadas no art. 16 da Lei 8.080/1990 e, no caso de epidemia instalada, no âmbito da declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – Espin, planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas empregadas (art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 7.616/2011 c/c art. 16, § 1º da Lei 8.080/1990), declarada pela Portaria GM/MS 188/2020.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

36.10. O conteúdo aberto do art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 7.616/2011 (planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas empregadas) amplia o leque de ações que o Ministério da Saúde poderia utilizar para o enfrentamento da pandemia, e, nesse caso, monitorar insumos e medicamentos essenciais inseridos nesse campo de atuação.

36.11. Cotejando-se os dispositivos citados, bem como as respostas apresentadas, entende-se que o Ministério da Saúde não está exercendo o seu papel de coordenador dos sistemas de vigilância epidemiologia e sanitária, transferindo os recursos, sem possuir e exercer papel proativo para evitar ou mitigar situações que escapam do controle da direção estadual do SUS, sem perder de vista que as ações de coordenação devem ser construídas de forma ascendente em uma interpretação extensiva do art. 36 da Lei 8.080/1990.

36.12. A situação causa preocupação, em meio à pandemia, pois o papel de planejamento e coordenação central do Ministério da Saúde, em termos de sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária pode ficar comprometido, e por conseguinte não exercer plenamente a sua competência elencada no art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 1º da Lei 8.080/1990, bem como do art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 7.616/2011.

36.13. No caso do desabastecimento de oxigênio em Manaus, como dito antes, o Ministério da Saúde precisou ser demandado pelo governo estadual, quando a situação estava atingindo o colapso, para buscar soluções para mitigar o problema. Caso o Ministério da Saúde possuísse informações tempestivas sobre o consumo daquele item, em razão do aumento dos casos e das pressões por mais leitos nos hospitais e unidades de saúde, poderia, como órgão central e coordenador da política nacional de saúde, ter prestado apoio tempestivo para evitar ou mitigar o desfecho de desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus.

36.14. O monitoramento do oxigênio medicinal acerca de seu consumo, produção, tempo de ressuprimento, principais fornecedores, logística de distribuição, bem como de medicamentos e insumos considerados estratégicos, é atividade que deve ser sistematizada, em nível ministerial, para que se conheça toda a sistemática da cadeia produtiva, de transporte, distribuição e consumo, para possibilitar intervenção ministerial com informações adequadas a fim de desencadear um plano organizado, com outros atores envolvidos (fornecedores, transportadores, órgãos de controle de transporte, Anvisa, Ministério da Defesa, Ministério da Economia) para evitar ou mitigar situações adversas, como a ocorrida em Manaus.

36.15. Pelo que foi apresentado de informações e documentos nestes autos, na ocorrência de desabastecimento de oxigênio medicinal, restou evidenciado que não havia monitoramento pelo Ministério da Saúde, transparecendo que a demanda do item não estava no radar das prioridades, como ocorria no caso de medicamentos, leitos, vacina e seringas. Ainda, como analisado no item 39.3, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas não exercia o controle diário/semanal do oxigênio, deixando tal providência a cargo do fornecedor. Tais fatos evidenciam que este item não estava entre os itens considerados críticos para efeito de controle efetivo tanto pela SES-AM como pelo Ministério da Saúde. Acreditava-se na capacidade de fornecimento da empresa contratada e na logística de distribuição, as quais colapsaram e levaram à rede de saúde ao desabastecimento no mês de janeiro de 2021.

36.16. A situação provoca alerta de risco de possibilidade de novas ocorrências de desabastecimento em outros pontos do território nacional, pois, via diligência, ao ser solicitado da UJ informações sobre plano de contingência nacional para enfrentamento de situações de excesso de demanda de leitos para Covid-19, nos estados brasileiros, para que não haja falta de atendimento de pacientes, seja pela ausência de estrutura física, por falta de profissionais ou falta de insumos médico-hospitalares, como ocorreu com a falta de oxigênio medicinal em Manaus/AM e Faro/PA, o setor competente (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde) se limitou a informar os recursos para abertura de leitos em Manaus.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

36.17. Considerando que a pandemia de Covid-19 não apresenta um horizonte definido de seu término, é curial que o Ministério da Saúde exerça o papel definido no art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", combinado com o § 1º da Lei 8.080/1990 e art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 7.616/2011, para evitar que a situação ocorrida em Manaus, em janeiro de 2021, volte a ocorrer em outras unidades da federação. Nesse sentido, deve buscar informações junto aos entes subnacionais, com periodicidade de segurança, para monitorar e coordenar os medicamentos e insumos estratégicos, a exemplo do oxigênio medicinal, sem prejuízo de o controle direto e efetivo continuar sendo exercido pelos entes subnacionais de acordo com suas necessidades.

36.18. O que não se admite, especialmente no meio de uma pandemia, é a falta de controle do consumo de insumos e medicamentos pelos entes subnacionais, e falta de informações para subsidiar a coordenação e o monitoramento dos insumos e medicamentos estratégicos pelo Ministério da Saúde, bem como o órgão ministerial não buscar essas informações. A atuação preventiva exige o controle e a disponibilização de informações sobre a execução das ações em saúde, considerando a dificuldade na obtenção de insumos e medicamentos em prazos e quantidades necessários para atender a demanda, principalmente em localidades onde a logística exige maior tempo e estrutura multimodal para cumprir o tempo de ressuprimento, como ocorre no estado do Amazonas.

36.19. Acerca do não exercício da coordenação e do monitoramento, especialmente do oxigênio medicinal, que passa a ser item estratégico nesse cenário de pandemia, nos termos do art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", combinado com o § 1º da Lei 8.080/1990, art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 7.616/2011 e Portaria GMS/MS 188/2020, verifica-se que, desde o início da pandemia até hoje, o Ministério da Saúde não exerceu essa competência no tocante ao monitoramento desse item, ficando o controle a cargo dos entes subnacionais, contratantes dos fornecedores.

36.20. O colapso do sistema que levou ao desabastecimento de oxigênio ocorrido em Manaus, em janeiro de 2021, poderia ter ocorrido em qualquer outra época de pico, pretérito ou futuro, pois a falta de controle e monitoramento, seja pelo ente subnacional, seja pelo Ministério da Saúde, aumenta significativamente o risco de falta desse insumo. O controle e o monitoramento do nível de consumo e o controle da evolução da doença na busca de leitos clínicos e de UTI pode ser o meio preventivo para evitar ou mitigar que situações como essa não voltem a ocorrer.

36.21. No processo TC 014.575/2020-5, que versou sobre o acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde (inclusive órgãos e entidades vinculados) para o combate à crise gerada pelo Covid-19, até o quinto ciclo, a equipe de auditoria apresentou a seguinte situação da problemática do oxigênio medicinal (peça 403 daquele processo):

> *558. Conforme constante na página eletrônica do Ministério da Saúde, o Governo Federal, por meio do MS, colocou em prática o Plano Oxigênio Brasil, com o objetivo de dar suporte aos entes federativos no abastecimento de oxigênio medicinal durante a pandemia da Covid-19.*
>
> *559. O Ministério da Saúde anunciou, entre outras medidas, a redistribuição de concentradores, cilindros e usinas de oxigênio enviados ao Amazonas, no início do ano, para os estados do Rio Grande do Norte, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Acre e a aquisição de concentradores de oxigênio na China e nos Estados Unidos, com apoio da iniciativa privada, com previsão de chegada para a primeira semana de abril.*
>
> *560. A Anvisa, por sua vez, adotou medidas excepcionais para mitigar o risco de desabastecimento de oxigênio medicinal nas unidades hospitalares, destacando-se a flexibilização de instrumentos regulatórios necessários ao aumento da capacidade produtiva, formalizada pelas Resoluções da Diretoria Colegiada 461/2021 e RDC 482/2021.*
>
> *561. A Anvisa, outrossim, publicou o Edital de Chamamento Público 5/2021, convocando fabricantes, envasadores e distribuidores de oxigênio medicinal, nas formas farmacêuticas líquido e gás, a fornecerem informações sobre a capacidade de fabricação, envase e distribuição, respectivos estoques disponíveis e quantidade demandada (nos últimos sessenta dias, para o envio da primeira informação; e semanal, para as seguintes) pelo setor público e privado.*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

> *562. As informações serão coletadas pelo prazo de 120 dias, a contar da data de publicação do edital, prorrogável, por decisão da Agência, e serão prestadas em caráter confidencial.*
>
> *563. A Anvisa, a partir de 13/3/2021, passou a disponibilizar, em seu site, dados gerais relativos à produção, estoque, comercialização e consumo, por entes públicos e privados, de oxigênio medicinal (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzYwNWU1MDEtNjk0Ny00MjczLTk1NWUtMmFlNzVhYTM3ZTk3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=ReportSection255cb87f555de69e1841).*
>
> *564. Destaque-se ainda que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa 1.929, de 26/3/2020, priorizando o desembaraço aduaneiro de produtos de uso na pandemia, em lista com mais de noventa itens, dentre os quais o oxigênio medicinal.*
>
> *565. As medidas adotadas pelo MS para garantir o abastecimento do oxigênio medicinal continuarão a ser acompanhadas por meio da representação instaurada.*

36.22. A situação de emergência desencadeada pela pandemia exige que medidas de controle e monitoramento efetivas sejam adotadas pelas autoridades competentes, considerando a essencialidade do oxigênio medicinal decorrente do aumento da demanda por leitos. Assim, o Ministério da Saúde, juntamente com outros órgãos que compõem a CIT e CIB, deve possuir instrumentos que possibilitem atuação preventiva e tempestiva para atuar naquelas situações que exigem a coordenação central e para isso, dispor de informações necessárias de acompanhamento para tomada de decisão eficaz, principalmente com situações isoladas de desabastecimento, como as ocorrências noticiadas no interior de Pernambuco e de São Paulo no final do mês de maio, e pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, de abril, que alerta a possibilidade de faltar oxigênio em 625 municípios (peça 102).

36.23. Não obstante o acima dito, a falta de monitoramento do oxigênio medicinal foi uma ***situação inusitada e extraordinária****, não se vislumbrando, a priori, responsabilização dos agentes públicos da pasta ministerial, uma vez que essa sistemática não tinha sido feita desde o início da pandemia, que não estava clara essa atribuição ministerial, em virtude do conteúdo aberto do art. 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011, e ainda que a informação com dados mensais/diários de consumo não foi repassada pelo gestor estadual, até porque tal procedimento não estava sistematizado, e, portanto, não se vislumbra a presença de dolo ou erro grosseiro, nos termos do art. 28 do Decreto-Lei 4.657/1942.*

36.24. Corroborando com este entendimento, o art. 8º do Decreto 9.830/2019, que regulou o disposto nos artigos de 20 a 30 do Decreto-Lei 4.657/1942, estabelece que:

> *Art. 8º Na interpretação de normas sobre gestão pública,* ***serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais*** *do agente público e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.*
>
> *§ 1º Na decisão sobre a regularidade de conduta ou a validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, serão consideradas as* ***circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram*** *a ação do agente público. (grifo nosso)*

36.25. Todavia, a partir daquele momento, necessita-se um controle sobre produção, demanda e distribuição, de forma estratégica e centralizada, com a finalidade de ter soluções ágeis e efetivas para evitar ou mitigar desabastecimento nos vários pontos do território nacional, caso picos de consumo venham a ocorrer, devendo ser elaborado plano de ação para o exercício do monitoramento do oxigênio medicinal de forma centralizada para adoção de medidas adequadas quando a situação assim requerer.

36.26. Considerando ainda que o abastecimento de oxigênio medicinal, seja por meio envasado ou não envasado, passou a assumir importância de item crítico, mesmo com a redução de ocupação de leitos clínicos e de UTI, e diante do surgimento de variantes de preocupação do vírus Sars-Cov-2,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

entende-se que o Tribunal pode manter o acompanhamento das ações realizadas pelo Ministério da Saúde acerca do seu monitoramento no TC 015.125/2021-1, que sucedeu o TC 014.575/2020-5.

36.27. Diante do exposto, a proposta foi de determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 30 dias, elaborasse plano de ação, para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, com elementos indicativos mínimos de consumo, tanto de gás não envasado (oxigênio líquido) e envasado (cilindros), preferencialmente em sistema informatizado, para que possibilite, de forma preventiva, o controle efetivo da unidade local e o monitoramento estratégico pelo órgão de saúde nacional, enquanto perdurar a Espin, estabelecendo, pelo menos, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos de implementação.

36.28. Em razão do que dispõe o art. 14 da Resolução TCU 315/2020, que estabelece que a unidade técnica instrutiva deve oportunizar aos destinatários das deliberações a apresentação de comentários sobre as propostas de determinação e/ou recomendação, foi realizada reunião, no dia 14/9/2021, na plataforma Teams, para apresentação da proposta de determinação com representantes da Secretaria Executiva, Coordenação Geral do Controle Interno, Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas e Órgãos de Controle, Departamento de Logística em Saúde e Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

36.29. O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Logística em Saúde, considera que o controle e monitoramento do consumo do oxigênio medicinal deve ser feito pelos entes subnacionais; que competiria ao ministério prestar apoio, quando fosse demandado; que o controle do consumo de oxigênio é uma atividade que exige conhecimento técnico e equipamentos para medição do produto nos tanques criogênicos; que mesmo o oxigênio envasado é difícil de medir, pois muitas vezes é substituído antes de seu consumo integral; que o cumprimento da determinação envolve pactuação a nível da CIT, pois os dados deveriam ser alimentados pelos entes subnacionais, os quais teriam dificuldades de obter as informações; e que o prazo para elaboração do plano de ação deveria ser maior.

36.30. Como já abordado nesta instrução, as competências do Ministério da Saúde, nos termos do art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", combinado com o § 1º da Lei 8.080/1990, art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 7.616/2011 e Portaria GMS/MS 188/2020, exigem postura proativa para planejar, coordenar, organizar e controlar a ações de saúde pública nas emergências públicas inusitadas.

36.31. Entende-se que a tarefa de monitoramento do oxigênio medicinal pelo órgão central, além de ser incipiente, está envolvida pelos problemas de obtenção de informações tempestivas e fidedignas prestadas pelos entes subnacionais, a exemplo da alimentação do sistema Siops, sobre os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para os entes subnacionais e da alimentação sobre as vacinas aplicadas na população, como identificado no acompanhamento das ações realizadas pelo Ministério da Saúde, no sexto ciclo, nos autos do processo TC 015/125/2021-5.

36.32. Todavia, a situação de desabastecimento de oxigênio ocorrida em Manaus, apesar de ser uma situação inusitada no país, esteve cercada por diversas falhas de procedimentos e informações narradas nesta instrução, que resultaram no colapso do sistema.

36.33. Neste sentido, o órgão ministerial, no mínimo, deve ter meios de saber, antecipadamente, a situação dos entes subnacionais, colocando o oxigênio medicinal no radar de seu monitoramento, a exemplo do que é feito com os medicamentos de intubação (monitorado pelo Conass), leitos, insumos, vacinas e equipamentos.

36.34. Acolhe-se, no entanto, o pedido acerca de aumentar o prazo para elaboração do plano de ação e mantem-se a proposta de determinação, com os ajustes necessários.

36.35. Face o exposto, propõe-se, com fundamento nos arts. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, 16, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.080/1990 e 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011,

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de sessenta dias, elabore plano de ação, que especifique as ações a serem tomadas, seus responsáveis e os prazos para implementação, para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, com elementos indicativos, de pelo menos, volume atual, tempo de ressuprimento, capacidade de ressuprimento do fornecedor local, tipo de fornecimento (tanques criogênicos, cilindros, usinas), consumo médio, estoque de segurança, periodicidade dessas informações, preferencialmente em sistema informatizado, para que possibilite, de forma preventiva, o controle efetivo da unidade local e o monitoramento estratégico pelo órgão de saúde nacional, enquanto perdurar a Espin.

Resposta da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (peças 81-101)

37. Por meio do Ofício 1994/2021-ASJUR/SES-AM, de 6 de maio de 2021, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) apresentou informações e juntou documentos acerca da diligência realizada.

Ocorrência: c.1) informações sobre o volume de oxigênio diário consumido pelo estado do Amazonas, separando capital e interior, no período de 1º/7/2020 a 31/1/2021;

38. A Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas informou que:

38.1. O fornecimento de oxigênio hospitalar é um serviço prestado por terceiro sob regime basicamente de monopólio, à semelhança do que ocorre, por exemplo, com o serviço de energia elétrica, em que a empresa fornece, afere, audita e fatura os serviços prestados, além de ser a detentora de todos os meios necessários à prestação dos serviços, como instalação de tanques criogênicos, operações de logística e equipes técnicas especializadas.

38.2. É mera cliente e usuária do referido serviço, através de contrato administrativo, ou seja, que não produz, não envasa, não distribui e muito menos fornece oxigênio medicinal às unidades de saúde da capital e interior.

38.3. O fornecimento de oxigênio não é uma atividade ou serviço público sujeito à regulamentação do estado. Significa que o setor não está no raio de competência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, por exemplo, sendo que a única forma de regulação é relativa ao gás medicinal, cuja competência é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Logo, justamente pela própria natureza do serviço, a SES-AM não exerce papel de "agência reguladora" estadual, de modo que não detém posse direta das referidas informações relacionadas à produção, consumo e distribuição dos gases medicinais, que pertencem exclusivamente às próprias empresas do setor.

38.4. O fornecimento de oxigênio não é uma atividade fim da SES-AM, que deva ser prestada diretamente pelo estado, mas sim uma atividade secundária, contratada e prestada por ente privado.

38.5. Em razão da grave crise sanitária ocorrida em janeiro de 2021, a secretaria manteve intensos diálogos com a empresa White Martins, contratada para fornecimento de oxigênio à rede pública de saúde, com o objetivo de ter acesso aos dados mantidos pela empresa relacionados com a temática em questão.

38.6. Os dados de consumo diário da rede pública de saúde, capital e interior, é fornecido diretamente pela empresa White Martins, todavia, tais dados envolvem apenas aquelas unidades de saúde que possuem tanques de oxigênio líquido, cuja aferição de consumo é feita através de telemetria, por meio dos sistemas mantidos pela contratada.

38.7. Considerando a disponibilização dos dados pela empresa contratada, a secretaria vem elaborando e testando painéis de monitoramento do nível de oxigênio das unidades da rede pública da saúde, para auxiliar no controle, acompanhamento e monitoramento da referida demanda, no formato de Dashboards e Power BIs.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

38.8. Quanto ao quesito específico do item c.1, encaminha planilha excel contendo todos os dados de consumo de oxigênio da rede pública de saúde das unidades com tanque de oxigênio líquido, capital e interior, desde 1º de janeiro de 2020 até 18 de abril de 2021, conforme dados disponibilizados pela empresa contratada (peças 100-101).

Ocorrência: c.2) informação de quando tomou conhecimento que a empresa White Martins não teria condições de atender a demanda excedente de oxigênio, que acabaram por levar ao desabastecimento da rede de saúde.

39. A Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas informou que:

39.1. As dificuldades com o gás oxigênio na rede pública de saúde do estado do Amazonas somente foi informado à SES-AM pela empresa White Martins na tarde do dia 7/1/2021, em reunião informal, ocasião em que o fornecedor, na pessoa do Sr. Petrônio Bastos, comunicou que haveria certa dificuldade no abastecimento de oxigênio, mas que, no sábado, dia 9/1/2021, chegaria uma carreta transportando o insumo e, após, novas carretas seriam enviadas à Manaus a cada 2 (dois) dias, e a situação estaria estabilizada.

39.2. No mesmo dia 7/1/2021, à noite, o representante da White Martins pediu novamente uma pauta para tratar da questão do oxigênio, por meio de reunião informal na SES-AM, com participação do Secretário de Saúde e da Secretária do Fundo Estadual de Saúde.

39.3. Na referida noite do dia 7/1/2021, o Secretário de Saúde entrou em contato por meio de ligação telefônica com o Ministro da Saúde à época, General Eduardo Pazuello, para comunicar as dificuldades apresentadas pela empresa White Martins referentes ao abastecimento de oxigênio, bem como para noticiar de que essa teria cilindros para trazer de Belém-PA, sendo necessário auxílio para seu transporte.

39.4. Nesse momento, foi informado pelo Ministro que o Comando Conjunto estava à disposição da Secretaria, a qual elaborou o Ofício 0145/2021-GAB/SES-AM, assinado às 22:30:28, solicitando urgente apoio do Comando Militar da Amazônia (peça 82), para realização do translado de oxigênio de Belém/PA para o Amazonas, objetivando vencer, além das barreiras logísticas, o tempo, tendo em vista a informação repassada pela empresa White Martins de que possuía estoque do insumo naquele Estado.

39.5. Nas últimas horas do dia 7/1/2021, por meio de contato telefônico, a White Martins informou que, em razão dos altos índices de consumo de oxigênio na rede pública da saúde, necessitaria que o estado fosse "retirar" oxigênio junto a um pequeno e único concorrente local, Carboxi Gases.

39.6. Para formalizar o pleito, às 00h03min do dia 8/1/2021, a White Martins encaminhou à SES-AM carta eletrônica (peça 83) informando acerca do aumento exponencial do consumo de gases, indicando a empresa Carboxi como possível mantenedora do produto que poderia ser disponibilizado, em razão do estado de emergência.

39.7. Em nenhum momento, a empresa White Martins citou a possibilidade de desabastecimento de oxigênio na rede, mas tão somente dificuldades logísticas pontuais e momentâneas. Ato contínuo, após o recebimento da comunicação formal pela fornecedora, considerando a urgência do caso e a completa impossibilidade de instrução de regular processo de contratação direta, fez-se a requisição administrativa de oxigênio da empresa Carboxi.

39.8. A secretaria instaurou o processo administrativo 01.01.017101.000378/2021-63 e expediu à empresa Carboxi, na manhã do dia 8 de janeiro de 2021, a Notificação Extrajudicial de Requisição Administrativa 01/2021-GAB/SES-AM (peça 84), objetivando requisitar 20 mil m³ de oxigênio líquido. Todavia, foram retirados tão somente 6.469 m³ de oxigênio (peça 85), disponíveis na empresa por ocasião do cumprimento da requisição.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

39.9. Em razão da requisição administrativa, foi expedido o Ofício 0161/2021 - GAB/SES-AM, de 8 de janeiro de 2021 (peça 86), em complemento ao Ofício 0145/2021-GAB/SES-AM encaminhado ao Comando Militar da Amazônia, informando que após a mencionada requisição constatou-se que a necessidade daquele momento da secretaria seria o transporte aéreo de apenas 350 (trezentos e cinquenta) unidades de cilindros de oxigênio de 70kg de Belém-PA para Manaus, desonerando aquele Comando dos custos operativos do pleito anterior.

39.10. No dia 10/1/2021 (domingo), chegou à Manaus a comitiva do Ministro de Saúde, composta pelo Secretário de Assistência Especializada, Secretário de Atenção Primária, Secretária de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, além de nova equipe técnica para apoio às ações e resposta ao estado do Amazonas.

39.11. A partir de então, o Governo do Estado do Amazonas, com apoio do então Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, instituiu, na data de 11 de janeiro de 2021, um Comitê de Comando Conjunto, através do fortalecimento do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento e Combate ao Covid-19 do estado do Amazonas, com inclusão de membros da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa/Manaus e das Forças Armadas do Brasil.

39.12. Apenas no dia 13/1/2021, em reunião que visava monitorar o abastecimento de oxigênio, realizada no Comitê Interinstitucional de Enfrentamento e Combate ao Covid-19 do estado do Amazonas, a empresa White Martins, convocada (peça 87), expôs uma apresentação e informou que sua capacidade de fornecimento de oxigênio era de 25.000 m³/dia, ao passo que a necessidade diária das redes pública e privada de saúde ultrapassava o patamar de 76.500 m³/dia, perfazendo um déficit diário de 48.500 m³.

39.13. Ao final da reunião, a empresa afirmou que só teria oxigênio suficiente para abastecimento até às 18h do dia seguinte (14/1), solicitando então mais apoio para a realização de maior quantidade de voos para transportar oxigênio.

39.14. Horas após o término da reunião, o representante da empresa entrou em contato por meio de ligação telefônica para informar que, na verdade, o oxigênio começaria a faltar na capital às 6h da manhã do dia 14/1/2021. Foi a partir desse momento, então, que se decidiu, conjuntamente, pelo início do plano emergencial de "evacuação" de pacientes internados na rede pública de saúde para outros estados da federação, com auxílio e protagonismo das equipes do Ministério da Saúde e Ministério da Defesa.

39.15. Durante toda a madrugada do dia 13 para 14 de janeiro e avançando durante a noite do dia 14, as equipes da Secretaria de Estado de Saúde, Força Nacional do SUS e Forças Armadas do Brasil trabalharam incessantemente no planejamento e execução do plano de "evacuação", adequadamente intitulado de "Cooperação entre os Estados", todavia, todos os pacientes triados e selecionados para transferência na noite do dia 14/1/2021 desistiram de última hora, frustrando totalmente o planejamento, execução e trabalho das equipes técnicas nesta data.

39.16. Novo voo foi reagendado para decolar às 6h da manhã do dia 15 de janeiro da Base Aérea de Manaus e imediatamente as equipes iniciaram nova busca ativa de pacientes da rede pública de saúde, enfrentando a segunda madrugada consecutiva de trabalho incessante, tendo conseguido a concordância de apenas 9 (nove) pacientes de todos os triados e com perfil clínico de transporte e, no horário planejado, o primeiro voo transferindo pacientes Covid-19 decolou de Manaus com destino ao Hospital Universitário do Piauí, em Teresina, chegando ao respectivo destino com sucesso.

Ocorrência: c.3) os estudos preliminares para elaboração do projeto básico para celebração do 7º Termo Aditivo ao Contrato 61/2016, celebrado com a empresa White Martins, para fornecimento de oxigênio medicinal, bem como o termo de referência, aditivos e contrato citados.

40. A Secretaria Estadual de Saúde informou que:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

40.1. O 7° Termo Aditivo ao Contrato 61/2016 teve como origem expediente oriundo da empresa White Martins, que requereu aditivo contratual de 25% em razão do excesso de consumo nos meses de abril a maio/2020, que consumiu mais do que a cota mensal planejada para o contrato, de modo que o valor total seria atingido meses antes ao seu ciclo anual de 12 meses. Portanto, tratou-se de um aditivo estritamente financeiro, objetivando estender o saldo de contrato, não se abordando assuntos como projeção ou aumento de consumo de oxigênio da rede estadual de saúde que, inclusive, àquela época não sinalizava qualquer possibilidade de desabastecimento ou exponencial aumento de consumo, como bem demonstram os dados históricos fornecidos pela empresa White Martins. Juntou cópia do contrato, seus aditivos e projetos básicos, e Processo 01.01.017101.006368/2020-50 (peças 88-96).

***Ocorrência: c.4) informações sobre a existência de plano de contingência para situações de aumento expressivo de leitos para Covid-19 que poderiam ocorrer a partir das festas do final do ano de 2020, apresentando-o, caso exista**.*

41. A Secretaria Estadual de Saúde informou que:

41.1. À época, encontrava-se em execução, desde o início de outubro/2020, o Plano Executivo de Contingência Estadual para o Recrudescimento da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus Covid-19 (peça 97), o qual foi elaborado com base numa projeção através de calculadora epidêmica desenvolvida pela Universidade de Brasília, com apoio da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS/OMS), tendo como principal ponto de cálculo o percentual de isolamento social, sendo realizada projeção de ampliação de leitos em 5 (cinco) fases, tendo como metodologia para mudança de fases o atingimento de 75% da taxa de ocupação de leitos Covid na rede pública.

41.2. A primeira e segunda fases ocorreram ainda no mês de novembro de 2020, seguida da terceira fase, iniciada na data de 23 de dezembro/2020, tendo perdurado apenas 5 (cinco) dias, considerando o aumento vertiginoso e abrupto da taxa de ocupação no referido período, forçando o Governo do Estado a prontamente iniciar as medidas necessárias ao início da quarta fase do plano de contingência, independentemente da total conclusão da fase anterior.

41.3. Todas essas modificações e mudanças repentinas na execução do novo plano de contingência tiveram como pano de fundo a alta taxa de ocupação de leitos Covid, levando as unidades de saúde a um nível de contingência "roxa", conforme portaria de regulação de urgência e emergência. Tal situação se deu em virtude da descoberta de uma nova cepa do vírus Coronavírus (variante P.1), conforme Nota Técnica 2021/01 – Rede Genômica Fiocruz/Ministério da Saúde, publicada dia 12/1/2021, mudando totalmente as características da doença.

41.4. A P.1 é uma das 18 variantes do novo coronavírus já mapeadas no Amazonas. O estudo realizado pela Fiocruz Amazônia, em parceria com a FVS-AM, confirmou a origem da P.1 e um aumento substancial na frequência dessa variante nas amostras analisadas. De acordo com o estudo, entre as amostras analisadas, a variante P.1 já respondia, em dezembro, por 51% dos casos. Já no dia 13 de janeiro, esse percentual aumentou para 91%.

41.5. Foi identificada a circulação dessa variante em 11 municípios do Amazonas, conforme estudos realizados em janeiro de 2021. Um trabalho subsequente comprovou que a P.1 possui maior afinidade pelo receptor humano e é mais resistente à neutralização por anticorpos, o que poderia justificar uma maior transmissibilidade. De fato, até novembro não houve qualquer detecção de P.1 ou mesmo de um ancestral mais próximo que as sequências conhecidas. No entanto, a P.1 foi encontrada em cerca de 35% das amostras de dezembro de 2020 e em mais de 75% das amostras em janeiro de 2021, corroborando o maior potencial de transmissão da P.1.

41.6. Em razão das novas características da doença, novos planejamentos foram necessários. Assim, o número de leitos da rede estadual aumentou em porcentagem nunca visto, para que o maior

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

número de pacientes fosse atendido. Em paralelo, se fez necessário o aumento também de insumos, equipamentos e recursos humanos.

Ocorrência: c.5) justificativas pela não comunicação ao Ministério da Saúde, em novembro ou dezembro, sobre a possível situação de desabastecimento de oxigênio em Manaus, que poderia ocorrer no início de janeiro de 2021.

42. A Secretaria Estadual de Saúde informou que:

42.1. A resposta, um tanto simples, pode ser sintetizada no sentido de que em novembro ou dezembro de 2020 não havia o menor indicativo de desabastecimento de oxigênio no estado do Amazonas.

42.2. Os dados apresentados pela empresa White Martins em coletiva do Governo do Estado do Amazonas, em 14 de janeiro de 2021, indicam que após a primeira alça epidêmica nos meses de abril e maio de 2020, o consumo de oxigênio da rede estadual de saúde estabilizou-se em um consumo médio de 13.262,10 m³/dia, compreendendo o período de 1º de junho de 2020 a 30 de novembro de 2020, considerando a rede pública e privada. Por outro lado, ampliando-se o período supracitado para incluir o mês de dezembro/2020, o consumo médio representa 14.315,60 m³/dia, igualmente considerando a rede pública e privada.

42.3. No mês de janeiro de 2021, o consumo de oxigênio na rede de saúde do Amazonas alcançou patamares inéditos e históricos em curtíssimo espaço de tempo, com crescimento abrupto sem qualquer precedente ou previsibilidade, representando um consumo médio de 59.381,20 m³/dia, atingindo o ápice em 28 de janeiro de 2021, quando o consumo de oxigênio atingiu o patamar de 73.686,20 m³.

42.4. Em nenhum momento se cogitou falar em desabastecimento ou incapacidade produtiva de uma das maiores empresas de oxigênio medicinal e industrial do Brasil porque não havia e não houve, durante toda a primeira onda epidêmica, qualquer sinal, comunicado ou alerta da possibilidade de desabastecimento da rede estadual de saúde. Como relatado anteriormente, o início das dificuldades no abastecimento de oxigênio na rede pública de saúde no estado do Amazonas somente foi comunicada à SES-AM pela empresa White Martins no dia 7/1/2021, em reunião informal à noite, quando a referida empresa, na pessoa do Sr. Petrônio Bastos, informou que haveria certa dificuldade no abastecimento de oxigênio, mas que, no sábado, dia 9/1/2021, chegaria uma carreta transportando o insumo e, após, novas carretas chegariam à Manaus a cada 2 (dois) dias, e a situação estaria estabilizada.

42.5. Anteriormente ao dia 7/1/2021, em momento algum a empresa White Martins citou a possibilidade de desabastecimento de oxigênio na rede, tendo informado no referido dia tão somente dificuldades logísticas pontuais e momentâneas.

42.6. Encaminhou, em 30/12/2020, o Ofício 6672/2020 - SEAC/SES-AM (peça 98) ao Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, noticiando as ações de enfrentamento à Covid-19 até então adotadas e que, mesmo diante de todas essas medidas, os números de casos confirmados no estado do Amazonas continuavam crescendo, solicitando, assim, a possibilidade de envio de equipe de profissionais de saúde da Força Nacional do SUS para ajudar no monitoramento, orientação técnica, bem como operação local de suporte básico e avançado no atendimento à população nas unidades de saúde do estado, visando reduzir ao máximo o impacto que a pandemia pode causar à população.

42.7. Desde a primeira semana de janeiro de 2021, mais especificamente a partir do dia 3/1/2021, o estado do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde já contavam com atuação técnica presente do Ministério da Saúde, através das equipes da Força Nacional do SUS - FNS/MS. Nesse sentido, muitas das tratativas iniciais com o Ministério da Saúde não foram realizadas por meio de documentos formais, tendo em vista que as equipes do Ministério se encontravam como parte

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

integrante do Comitê de Crise do Governo do Estado, como profissionais designados para auxiliar no diagnóstico situacional. Logo, trabalhavam no mesmo ambiente físico que as equipes da Secretaria de Saúde e demais membros dos órgãos governamentais, de forma que a comunicação mais rápida naquele momento para possíveis resoluções era a verbal.

Ocorrência: c.6) informações da situação atual da capital e dos municípios do interior em relação ao abastecimento e consumo de oxigênio (ocupação de leitos, consumo de oxigênio diário, empresas fornecedoras e volume fornecido).

43. A Secretaria Estadual de Saúde informou que:

43.1. Como esclarecido anteriormente, não exerce papel de "agência reguladora" quanto aos insumos de gases medicinais, de modo que não se pode precisar com exatidão quantas empresas fornecedoras de oxigênio existem instaladas no estado do Amazonas, muito menos o volume fornecido por tais empresas, uma vez que tais informações são de cunho estritamente privado e, quiçá, protegidos pelas regras de sigilo industrial.

43.2. Conforme dados colhidos durante a grave crise sanitária do início de 2021, atinente à capacidade de produção e fornecimento de oxigênio, mister pontuar que o estado do Amazonas dispõe, em princípio, de apenas 2 (duas) empresas capacitadas para a produção do referido insumo, sendo elas a White Martins (contratada), com capacidade produtiva atual de aproximadamente 36mil m³/dia, conforme informado pela própria empresa e a Carboxi Gases, com capacidade produtiva de aproximadamente 10-12mil m³/dia, que foi alvo de requisição administrativa do estado no mês de janeiro/2021.

43.3. É importante pontuar que a White Martins é uma empresa multinacional brasileira que atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais, sendo uma subsidiária pertencente ao grupo Linde AG (The Linde Group), empresa alemã líder mundial em produção de gases. No estado do Amazonas, a White Martins detém aproximadamente 80% de todo o mercado medicinal e industrial de gases, e aproximadamente 98% do mercado hospitalar, público e privado.

43.4. A empresa Carboxi Gases é uma empresa de pequeno/médio porte, cujo seu maior cliente é o mercado hospitalar, público e privado do estado de Roraima, além de pouquíssimos hospitais particulares na capital amazonense. Fora as mencionadas empresas que produzem oxigênio, há ainda a empresa Nitron da Amazônia que, até onde se sabe, é apenas uma distribuidora que compra oxigênio de outros estados e transporta para o estado do Amazonas para atender ao mercado de varejo, bem como dois hospitais regionais do município de Parintins e alguns hospitais privados de pequeno porte na capital amazonense.

43.5. Quanto ao abastecimento e consumo de oxigênio da capital, passado o período relativo à grave crise sanitária vivenciada no período de janeiro até a primeira semana de março de 2021, o consumo de abastecimento da rede estadual de saúde se estabilizou em uma média de 19.667,30 m³/dia, considerando a rede pública e privada, sendo 15.176,80 m³/dia referente apenas à rede pública de saúde.

43.6. Em relação aos municípios do interior, primeiramente é importante esclarecer que a SES-AM não detém a gestão dessas unidades, uma vez que os municípios possuem gestão plena do sistema de saúde municipal, de modo que possuem responsabilidade das ações relacionadas não apenas à atenção básica de saúde, mas também em relação à média e alta complexidade, recebendo do Ministério da Saúde os recursos pertinentes para o custeio da referida gestão plena.

43.7 Embora alguns municípios do interior do estado do Amazonas sejam abrangidos pelo contrato administrativo celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa White Martins, a responsabilidade pela gestão hospitalar e da rede municipal de saúde daquelas localidades compete

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

exclusivamente aos próprios municípios, inclusive em relação às informações de abastecimento e consumo de oxigênio.

43.8. Ela e a empresa White Martins não possuem dados relativos ao consumo de oxigênio dos municípios, uma vez que a grande maioria deles utilizam cilindros de oxigênio, de modo que não é possível aferir, através de instrumentos/ferramentas automatizados(as), o consumo de oxigênio envasado, diferentemente do que ocorre com unidades de saúde que possuem tanques de oxigênio líquido, no qual a aferição é possível através de instrumentos de telemetria.

43.9. Visando o melhor acompanhamento nas unidades de saúde do interior, implementou um sistema para realizar o monitoramento de dados, os quais advêm das informações coletadas de um formulário, cujo preenchimento é de responsabilidade das unidades de saúde, sendo uma ferramenta tecnológica que visa o acompanhamento da situação do consumo de oxigênio nas unidades de saúde do interior, denominado de dashboard, cujo link de acesso está disponível para acesso público no site desta SES-AM (http://www.saude.am.gov.br/painel/fvscovid/).

43.10. No referido Dashboard as unidades de saúde do interior do estado do Amazonas informam, diariamente, dados relativos ao total de cilindros, cilindros vazios, cilindros cheios e cilindros em uso, além da situação de criticidade das respectivas unidades de saúde.

***Ocorrência: c.7) informação da existência ou se está sendo elaborado um plano de contingência para enfrentar nova situação de excesso de demanda por leitos de Covid-19 no ano de 2021, caso ocorram novas ondas de contaminação de Covid-19**.*

44. A Secretaria Estadual de Saúde informou que:

44.1. Em 22 de abril de 2021, finalizou a versão preliminar do novo Plano de Contingência Estadual para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 (peça 99), o qual possui um capítulo específico para tratar apenas da demanda de oxigênio.

44.2. No citado documento, é previsto o Plano de Capacidade Plena (PCP) cujo objetivo é garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto do insumo em conformidade com a demanda. Ademais, em seu item 7.9.4 e seguintes, são descritas as ações estratégicas, por fases, a serem realizadas considerando o volume de consumo diário máximo e estabelecendo níveis de segurança.

Análise das respostas da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas

45. A Secretaria de Estado de Saúde informou que não possuía ou possui controle do consumo de oxigênio fornecido para suas unidades de saúde, ficando a cargo da empresa White Martins, além do fornecimento, o controle e monitoramento do volume consumido.

45.1. O Secretário de Saúde alega que o volume de oxigênio consumido é calculado nos tanques de oxigênio por telemetria pela empresa fornecedora, uma das razões de a secretaria não realizar tal controle.

45.2. Os dados de consumo diário para atender a demanda da diligência foram fornecidos pela empresa e que o serviço não está sujeito à regulação pelo estado, não possuindo informações diretas relacionadas à produção, consumo e distribuição dos gases medicinais, que pertencem exclusivamente às próprias empresas do setor.

45.3. Em plena pandemia, situação em que um dos itens mais críticos para manter a vida dos pacientes em estado grave é o oxigênio medicinal em leitos de UTI ou em leitos clínicos, que necessitem de oxigenioterapia, não se controlar ou monitorar o consumo desse item é assumir risco de desabastecimento, principalmente quando existe um aumento exponencial de contaminação que leva contingentes elevados de pacientes em busca dos serviços de saúde.

45.4. A empresa fornecedora tem competência essencial de seu processo de trabalho para produção e distribuição desse insumo e até fazer o processo de controle da sua demanda nos tanques

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

de gás criogênico, porém o gestor de saúde não pode se omitir desse controle e monitoramento, ou não possuir informações de tais quantitativos diários, tendo em vista que as pressões por leitos de UTI e clínicos são de conhecimento primário dos agentes responsáveis pelos serviços de saúde, e não da empresa fornecedora.

45.5. O Secretário de Saúde alega que a empresa comunicou as dificuldades logísticas momentâneas e temporárias de abastecimento e que somente no dia 13/1/2021 informou da impossibilidade de atender as unidades de saúde nas quantidades elevadas que estavam sendo exigidas naquele período.

45.6. Fazendo uma digressão cronológica dos fatos acerca da falta de oxigênio na cidade de Manaus, com os dados apresentados, elaborou-se a Tabela 2 – Cronologia dos eventos da falta de oxigênio para se visualizar os fatos na linha do tempo:

Tabela 2 – Cronologia dos eventos da falta de oxigênio

Datas	***Ações***	***Peça***
16/7/2020	*White Martins solicita aditivo contratual de 25% relativo ao Contrato 61/2016 de fornecimento de oxigênio medicinal.*	*96, p. 1-2*
9/9/2020	*Nota Técnica do o Departamento de Contratos, Convênios e Acordos Internacionais/DCCAI- SES-AM informa que o contrato só pode ser aditivado em 21,9152%, pois já havia sido acrescido anteriormente (3,0848 %)*	*96, p. 53-55*
11/9/2020	*Engenharia Clínica sugere aumento de 46,9152%, alertando que o aumento de 21,9152% não atenderia a demanda até dezembro/2020*	*96, p. 60-64*
1/10/2020	*A Gerência de Execução Orçamentária do Fundo Estadual de Saúde informa da indisponibilidade orçamentária para atender o acréscimo de 46,9152%*	*96, p. 89*
13/10/2020	*Expediente do Secretário Executivo Adjunto de Gestão Administrativa encaminha o processo para Procuradoria Geral do Estado para que se manifeste acerca do acréscimo de 21,9152%*	*96, p. 92*
23/11//2020	*Assinatura do 7° Termo Aditivo ao Contrato 61/2016 - teve como origem expediente oriundo da própria empresa White Martins, que requereu* ***aditivo contratual de 25% em razão do excesso de consumo nos meses de abril à maio/2020****, que* ***consumiu mais do que a cota mensal planejada para o contrato****, de modo que o valor total do contrato seria atingido meses antes ao seu ciclo anual de 12 meses.*	*96, p. 246-247*
30/12/2020	*Secretaria de Estado de Saúde encaminhou, em 30/12/2020, o Ofício 6672/2020 - SEAC/SES-AM ao* ***Ministro da Saúde****, General Eduardo Pazuello,* ***noticiando as ações de enfrentamento à COVID-19 até então adotadas*** *e que, mesmo diante de todas essas medidas,* ***os números de casos confirmados no Estado do Amazonas continuavam crescendo****, solicitando* ***a possibilidade de envio de equipe de profissionais de saúde da Força Nacional do SUS para ajudar no monitoramento, orientação técnica, bem como operação local de suporte básico e avançado no atendimento à população nas Unidade de Saúde do Estado****, visando reduzir ao máximo o impacto que a pandemia pode causar à população.*	*98*
3/1/2021	*Desde a primeira semana de janeiro de 2021, mais especificamente a partir do dia* ***3/1/2021****, o Estado do Amazonas e a Secretaria de Estado de Saúde* ***já contavam com atuação técnica presente do Ministério da Saúde, através das equipes da Força Nacional do SUS - FNS/MS****.*	*81, p. 14*
7/1/2021	*Na* ***tarde do dia 7/1/2021****, em reunião informal, a empresa White Martins, na pessoa do Sr. Petrônio Bastos, comunicou que haveria* ***certa dificuldade no abastecimento de oxigênio****, mas que, no sábado, dia 9/1/2021, chegaria uma carreta transportando o insumo e, após, novas carretas seriam enviadas à Manaus a cada 2 (dois) dias, e a situação estaria estabilizada.*	*81, p. 3*
7/1/2021	***à noite****, o representante da White Martins pediu novamente uma pauta para*	*81, p. 3*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

	tratar da questão do oxigênio, por meio de reunião informal na SES-AM, com participação do Secretário de Saúde e da Secretária do Fundo Estadual de Saúde.	
7/1/2021	***Na noite do dia 7/1/2021**, o Secretário de Saúde entrou em contato por meio de ligação telefônica com o Ministro da Saúde a época, General Eduardo Pazuello, para comunicar quanto **às dificuldades apresentadas pela empresa White Martins** referente ao seu abastecimento, bem como **para noticiar de que essa teria cilindros para trazer de Belém-PA**, sendo necessário auxílio para seu transporte. Nesse momento, foi informado pelo Ministro que o Comando Conjunto estava à disposição desta Secretaria.*	*81, p. 3*
7/1/2021	*Imediatamente a Secretaria de Estado de Saúde elaborou o Ofício 0145/2021-GAB/SES-AM, assinado **às 22:30:28**, solicitando urgente apoio do Comando Militar da Amazônia, para realização do **translado de oxigênio de Belém/PA para o Amazonas**, objetivando vencer, além das barreiras logísticas, o tempo, tendo em vista a informação repassada pela empresa **White Martins de que possuía estoque do insumo naquele Estado**.*	*82*
07/1/2021	*Nas **últimas horas** do dia 7/1/2021, através de contato telefônico, a White Martins informou que, em **razão dos altos índices de consumo de oxigênio na rede pública da saúde**, necessitaria que o Estado fosse "**retirar" oxigênio junto a um pequeno e único concorrente local, Carboxi Gases**.*	*81, p. 4*
8/1/2021	*Como medida para formalizar o pleito, **às 00h03min do dia 8/1/2021**, a **White Martins encaminhou à Secretaria de Estado de Saúde Carta eletrônica informando acerca do aumento exponencial do consumo** de gases, **indicando a empresa Carboxi** como possível mantenedora do produto que poderia ser disponibilizado a esta SES-AM, em razão do estado de emergência.*	*81, p. 4*
8/1/2021	*Instauração de processo administrativo 01.01.017101.000378/2021-63 e expedição à empresa CARBOXI, na **manhã do dia 8 de janeiro de 2021, a Notificação Extrajudicial de Requisição** Administrativa 01/2021-GAB/SES-AM, objetivando requisitar **20 mil m³** de oxigênio líquido. Todavia, foram retirados tão somente **6.469m³** de oxigênio, disponíveis na empresa.*	*81, p. 4-5, e 84-85*
8/1/2021	*Ofício 0161/2021 - GAB/SES-AM, de 8 de janeiro de 2021, em complemento ao Ofício 0145/2021-GAB/SES-AM encaminhado ao Comando Militar da Amazônia, informando que após a mencionada requisição constatou-se que a necessidade atual, naquele momento, seria o **transporte aéreo de apenas 350** unidades de cilindros de oxigênio de **70kg de Belém-PA para Manaus**, desonerando aquele Comando dos custos operativos do pleito anterior*	*81, p. 5, e 86*
10/1/2021	*Chegou à Manaus a comitiva do Ministro de Saúde, composta pelo Secretário de Assistência Especializada, Secretário de Atenção Primária, Secretária de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, além de nova equipe técnica para apoio às ações e resposta ao Estado do Amazonas.*	*81, p. 5*
11/1/2021	*O Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, **instituiu o Comitê de Comando Conjunto**, através do fortalecimento do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento e Combate ao COVID-19 do Estado do Amazonas, com **inclusão de membros da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA/Manaus e das Forças Armadas do Brasil.***	*81, p. 5*
13/1/2021	*Apenas no dia 13/1/2021, em **reunião que visava monitorar o abastecimento de oxigênio,** realizada no Comitê Interinstitucional de Enfrentamento e Combate ao COVID-19 do estado do Amazonas, a **empresa White Martins**, convocada, expôs uma apresentação e informou que sua **capacidade de fornecimento de oxigênio era de 25.000 m³/dia**, enquanto que a necessidade diária das redes pública e privada de saúde ultrapassava o patamar de **76.500 m³/dia**, perfazendo um **déficit diário de 48.500 m³.***	*81, p. 5, 87*
13/1/2021	*Ao final da reunião, a empresa afirmou que **só teria oxigênio suficiente para abastecimento até 18h do dia seguinte (14/1),** solicitando então **mais apoio***	*81, p. 6*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

	para a realização de maior quantidade de voos para transportar oxigênio.	
13/1/2021	***Horas após o término da reunião**, o representante da empresa entrou em contato por meio de **ligação telefônica para informar** que, na verdade, o oxigênio começaria a **faltar na capital às 6h da manhã do dia 14/1/2021.***	*81, p. 6*
13/1/2021	*Foi a partir desse momento que se decidiu pelo início do **plano emergencial de "evacuação" de pacientes internados** na rede pública de saúde para outros Estados da federação, com auxílio e protagonismo das equipes do Ministério da Saúde e Ministério da Defesa.*	*81, p. 6*
14/1/2021	*Durante toda a **madrugada do dia 13 para 14 de janeiro e avançando durante a noite do dia 14**, as equipes da Secretaria de Estado de Saúde, Força Nacional do SUS e Forças Armadas do Brasil trabalharam incessantemente no planejamento e execução **do plano de "evacuação", adequadamente intitulado de "Cooperação entre os Estados**", todavia, todos os pacientes triados e selecionados para transferência na noite do **dia 14/1/2021 desistiram de última hora**, frustrando totalmente o planejamento, execução e trabalho das equipes técnicas nesta data.*	*81, p. 6*
15/1/2021	*Novo voo foi reagendado para decolar **às 6h da manhã do dia 15 de janeiro** da Base Aérea de Manaus e imediatamente as equipes iniciaram nova busca ativa de pacientes da rede pública de saúde, enfrentando a segunda madrugada consecutiva de trabalho incessante, tendo conseguido a **concordância de apenas 9 (nove) pacientes** de todos os triados e com perfil clínico de transporte e, no horário planejado, o primeiro voo transferindo pacientes Covid-19 decolou de Manaus com destino ao Hospital Universitário do Piauí, em Teresina.*	*81, p. 6-7*
28/1/2021	*Consumo médio de 59.381,20 m³/dia, atingindo o ápice **em 28 de janeiro de 2021**, quando o consumo de oxigênio atingiu o patamar de **73.686,20 m³***	*81, p. 13*

Fonte: própria produzida com informações da peça 81

45.7. Verifica-se que a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas ficou totalmente dependente de informações da fornecedora, a qual comunicou no dia 7/1/2021 as dificuldades logísticas para fornecimento e no dia 13/1/2021, informou do desabastecimento iminente.

45.8 As comunicações feitas ao Ministério da Saúde, no dia 7/1/2021, com pedido de apoio para transporte de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus, não retratou o real estado de iminente colapso que a cidade passaria na semana seguinte. Quando, no dia 13/1/2021, a White Martins finalmente relata a impossibilidade de atender a alta demanda, estava selada a vida dos pacientes nos dias seguintes, quando se instaurou o colapso no sistema de saúde.

*45.9. Ressalte-se que diligenciado por que não informou a situação do oxigênio em novembro ou dezembro de 2020 para o Ministério da Saúde, **o Secretário de Saúde informou que não havia indicativo dessa demanda. Todavia, a Engenharia Clínica, em 11/9/2020, havia sugerido aumento para o 7º Termo Aditivo ao Contrato 61/2016, de 46,9152%, pois o percentual de 21,9152% não atenderia a demanda até dezembro/2020**. Note-se que, em dezembro, havia indicativos de aumento de demanda por leitos em janeiro decorrente das festas de final de ano. Assim, a informação do Secretário de Saúde não tem sustentação nos pareceres internos das áreas técnicas.*

45.10. Caso houvesse controle e monitoramento pela SES-AM, se tivesse atuado preventivamente em conjunto com a fornecedora e demais órgãos governamentais federais (Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Forças Armadas, dentre outros), e se tivesse ouvido a área técnica interna, provavelmente desfecho diferente poderia ter ocorrido na capital do Amazonas.

45.11. Imputar a responsabilidade à empresa pelo desabastecimento de oxigênio da rede estadual de saúde não parece ter fundamento, tendo em vista que a empresa atendeu a demanda contratada e ainda foi além desse parâmetro, uma vez que buscava aditivo para se ver ressarcida dos excessos de oxigênio medicinal fornecido nos meses de janeiro a agosto de 2020 (peça 96, p. 68).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

Ressalte-se que a perspectiva de visão de produção de oxigênio medicinal da empresa produtora, que fornece para o setor público e privado, é diferente da perspectiva de visão do gestor da área de saúde, conhecedor da demanda por leitos, do número de infectados, do número de pacientes internados em leitos Covid-19 e não Covid-19, bem como do excesso de pacientes que ficam, nos hospitais e unidades de saúde, à espera por leitos, muitos deles com suporte ventilatório em leitos improvisados.

45.12. A situação aqui tratada difere da ocorrida na Ebserh, pois lá a empresa não cumpriu parcialmente a demanda contratada e, desde o dia 9/1/2021, não tinha abastecido o tanque de oxigênio criogênico.

45.13. Destaque-se que a falta de controle do consumo de oxigênio alegada pelo Secretário Estadual de Saúde significa assumir o risco de que as quantidades indicadas pela empresa como entregues à rede estadual estejam corretas, mesmo se fossem ofertadas em volumes menores, pois sem controle de demanda e do que está sendo recebido, eventuais diferenças não seriam de seu conhecimento.

45.14. Ainda, o aumento de novos leitos de UTI Covid-19 ensejaria o aumento da quantidade de oxigênio a ser contratada, porém não houve essa providência, considerando que o 7º Termo Aditivo ao Contrato 61/2016 tratou apenas de valor financeiro, e não de quantitativo. Aqui cabe destacar que a SES/AM utilizou o mesmo volume contratado de oxigênio medicinal antes da pandemia, fazendo aditivos pontuais para alcançar os 25%, quando, em razão da demanda por leitos de UTI e clínicos, com suporte ventilatório, poderia ter realizado estudos e contratado volume adicional, seja mediante procedimento licitatório, seja por contratação direta (peça 96, p. 53-54).

45.15. No novo plano de contingência estadual, foram alocadas responsabilidades para acompanhamento do consumo de oxigênio das unidades de saúde, demonstrando, portanto, a necessidade de controle e a responsabilidade da gestão estadual de saúde em ter números sobre controle e monitoramento.

45.16. Acerca da rede de saúde municipal, a SES-AM informou que, pela gestão plena, os serviços de saúde são prestados e os fornecedores contratados diretamente pelas prefeituras. Mesmo assim, elaborou-se um sistema de controle do consumo de oxigênio em cilindros, forma utilizada para o abastecimento da rede de saúde do interior do estado. Essa medida e a indicada no novo plano de contingência são embriões de um controle e monitoramento que podem impedir ou mitigar que situações como a ocorrida em janeiro de 2021 não volte a ocorrer no Amazonas.

45.17. Verifica-se ainda que os recursos que suportaram as aquisições de oxigênio são recursos próprios do estado do Amazonas (fonte 0100 – recursos do Tesouro) (peça 94, p. 9), motivo pelo qual propõe-se encaminhar a decisão adotada pelo Tribunal juntamente com cópia desta instrução ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao Ministério Público do Estado do Amazonas, bem como à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em razão do procedimento 1.13.000.000061/2021-04, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

CONCLUSÃO

46. O presente processo tratou da falta de oxigênio ocorrida no mês de janeiro de 2021, decorrente de um colapso no sistema de saúde decorrente do elevado número de contaminados pela Covid-19 e exponencial busca por leitos de UTI e clínico na rede pública e privada de saúde.

47. Inicialmente, a representação atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos artigos 235, parágrafo único, e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), podendo ser conhecida por este Tribunal, e no mérito considerá-la procedente, conforme análise empreendida ao longo desta instrução, com síntese abaixo.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

48. O exame buscou apurar a ocorrência das irregularidades, sendo diligenciados o Ministério da Saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh e o Governo do Estado do Amazonas/Secretaria Estadual de Saúde.

49. Analisadas as respostas e cotejando-se a documentação apresentada, entendeu-se que a falta de oxigênio no dia 14/1/2021 nas instalações do HUGV-Ebserh decorreu de falha no fornecimento da empresa White Martins, que em razão do excesso de demanda em toda rede não abasteceu o tanque de oxigênio criogênico no dia 9/1/2021, mantendo o hospital com bateria de cilindros, o que não foi suficiente para atender a demanda (itens 32.11-32.17), cabendo processo de apuração para possível aplicação de sanção ao fornecedor, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, não se vislumbrando, pelos elementos acostados aos autos, dolo ou erro grosseiro, nos termos do art. 28 do Decreto-Lei 4.657/1942.

50. Em relação à falta de oxigênio na rede estadual de saúde, as informações e os documentos apresentados apontam que o fornecedor cumpriu a demanda contratada, porém não conseguiu atender ao aumento exponencial de consumo, não ficando caracterizada a inexecução parcial de contrato. A situação teve como causa a falta de controle e monitoramento do consumo de oxigênio pela Secretaria Estadual de Saúde, a qual não dispunha de informações para tomar medidas preventivas e pedir apoio tempestivamente para evitar ou mitigar o colapso do sistema (itens 45.7-45.11). Considerando que o custeio do fornecimento de oxigênio foi com recursos próprios (fonte 100), sugere-se encaminhar a decisão adotada por esta Corte, juntamente com cópia da presente instrução, para o Ministério Público do Estado do Amazonas e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), bem como à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em razão do procedimento 1.13.000.000061/2021-04, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

51. Acerca do papel do Ministério da Saúde diante da ocorrência, constatou-se que o órgão não exerceu sua competência de controle e monitoramento dos insumos estratégicos a nível nacional, nos termos do artigo 16, inciso VI e § 1º, da Lei 8.080/1990 e artigo 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011 (itens 36.8-36.11).

52. Ainda, verificou-se que, pela falta do controle e monitoramento de oxigênio e do recrudescimento da pandemia, havendo notícias de desabastecimento em municípios do interior de Pernambuco e São Paulo, e ainda da pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), alertando a possibilidade de desabastecimento em 525 municípios, sugere-se, como medida necessária e urgente para mitigar ou evitar que a situação de Manaus não se repita, que o Ministério da Saúde elabore plano de ação para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, enquanto perdurar a Espin.

53. Por fim, sugere-se o apensamento desse processo ao TC 015.125/2021-1 para continuidade do acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde (inclusive órgãos e entidades vinculados) para o combate à crise gerada pelo Covid-19.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

54. O Ministério Público Federal encaminhou cópia da Notícia de Fato 1.13.000.000241/2021-88 sobre representação formulada pelo Deputado Estadual Dermilson Carvalho das Chagas, noticiando desvio de recursos por parte do Governo do Amazonas na ordem de R$ 56.688.723,11, de verbas exclusivas e emergenciais do combate à pandemia do Covid (peça 77).

55. Na análise do processo, o parquet federal informou que o autor faz acusações embasadas em relatório de despesa e receita do Governo do Estado do Amazonas, sem indícios de provas e/ou outros elementos que viabilizem a investigação, também não se tem notícia de nenhuma irregularidade específica e acrescentando ser a denúncia genérica, sem elementos que viabilizem a instauração de investigação no Ministério Público Federal ou que justifiquem sua juntada em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

procedimento em curso ou mesmo sua remessa ao Ministério Público Estadual e procedeu o arquivamento e a remessa ao TCU para conhecimento (peça 78).

56. Os documentos foram juntados a este processo, todavia, não apresentam elementos que possam subsidiar as análises aqui realizadas em razão de ser conteúdo genérico e sem indícios de irregularidades.

57. A Procuradoria da República no Amazonas instaurou o Inquérito Civil 1.13.000.000061/2021-04, que resultou na Ação de Improbidade Administrativa 1006436-58.2021.4.01.3200, que tramita em segredo de justiça, tendo por objeto a temática de falta de oxigênio em Manaus, tratamento precoce e transferência de pacientes para outros estados.

58. Tramita também na Justiça Federal do Distrito Federal ação penal 1022531-48-2021.4.01.3400 sobre os fatos ocorridos em Manaus.

59. Foi juntado o Despacho de 28/1/2021, do Ministro Relator Benjamin Zymler, prolatado nos autos do processo TC 000.463/2021-3, que versa sobre representação dos Senadores da República Rogério Carvalho, Humberto Sérgio Costa Lima, Jaques Wagner, Jean Paul Terra Prates, Paulo Renato Paim, Paulo Roberto Galvão da Rocha e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, dando conta de possíveis irregularidades praticadas pelo Ministério da Saúde na condução da crise gerada pelo novo coronavírus, a exemplo da crise do oxigênio em Manaus (peça 103-106).

60. Considerando que a temática tratada nestes autos relaciona-se com a representação, propõe-se envio da deliberação a ser proferida, com relatório e voto, aos representantes.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

61. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

I - conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014, para no mérito considerá-la procedente;

II - determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, 16, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.080/1990 e 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011, que, no prazo de sessenta dias, elabore plano de ação, que especifique as ações a serem tomadas, seus responsáveis e os prazos para implementação, para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, com elementos indicativos, de pelo menos, volume atual, tempo de ressuprimento, capacidade de ressuprimento do fornecedor local, tipo de fornecimento (tanques criogênicos, cilindros, usinas), consumo médio, estoque de segurança, periodicidade dessas informações, preferencialmente em sistema informatizado, para que possibilite, de forma preventiva, o controle efetivo da unidade local e o monitoramento estratégico pelo órgão de saúde nacional, enquanto perdurar a Espin;

III - determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, apresente ao Tribunal o resultado do processo de apuração de descumprimento parcial de contrato pela empresa White Martins, pela falta de fornecimento contínuo de oxigênio, em janeiro de 2021, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV)/Ebserh;

IV – encaminhar a decisão adotada pelo Tribunal à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, considerando os procedimentos de números processo 1.13.000.000061/2021-04 e 1.13.000.000241/2021-88, para conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes, informando que o Relatório e o Voto estão disponíveis em www.tcu.gov.br/acordaos e, caso queira, o Tribunal pode lhes encaminhar cópia desses documentos, sem custos;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

V – encaminhar a decisão adotada pelo Tribunal ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao Ministério Público do Estado do Amazonas para conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes, informando que o Relatório e o Voto estão disponíveis em www.tcu.gov.br/acordaos e, caso queiram, o Tribunal pode lhes encaminhar cópia desses documentos, sem custos;

VI – encaminhar a decisão adotada pelo Tribunal, para atendimento de demandas formalizadas na representação nos autos do processo TC 000.463/2021-3, que versa de representação dos Senadores da República Rogério Carvalho, Humberto Sérgio Costa Lima, Jaques Wagner, Jean Paul Terra Prates, Paulo Renato Paim, Paulo Roberto Galvão da Rocha e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, informando que o Relatório e o Voto estão disponíveis em www.tcu.gov.br/acordaos e, caso queira, o Tribunal pode lhes encaminhar cópia desses documentos, sem custos;

VII – apensar este processo ao TC 015.125/2021-1 para continuidade do acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde;

VIII - autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler."

3. O Ministério Público junto ao TCU assim se manifestou:

2. "Para melhor compreensão dos fatos, faz-se necessário, inicialmente, apresentar breve histórico processual.

***

3. A Unidade Técnica representou ao TCU com base nos seguintes argumentos (peça 4):

a. matéria publicada pela Agência Brasil em 13/1/2021 apontando aumento de consumo de oxigênio hospitalar em estabelecimentos públicos de saúde do Amazonas, que superou a média diária de consumo em mais de 11 vezes;

b. o governo federal estaria adotando medidas urgentes em conjunto com o governo do estado do Amazonas para tentar suprir os hospitais com insumos e oxigênio, mas tais medidas poderiam não ser suficientes para resolver a grave crise instalada naquela unidade da federação;

c. a Força Aérea Brasileira divulgou em 15/1/2021 a realização de missões emergenciais de transporte de insumos hospitalares, incluindo tanques de oxigênio;

d. matéria da Folha de São Paulo, publicada em 16/1/2021, noticiando que o governo federal teria ignorado alertas em série sobre falta de oxigênio em Manaus;

e. a matéria ser de competência do Tribunal, pois, conforme previsão constitucional, a responsabilidade quanto aos cuidados da saúde é comum aos entes federativos;

f. embora a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estabeleçam como princípio a descentralização dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal para estados e municípios, respectivamente, cabe, conforme o art. 16 da Lei 8.080/90, à direção nacional do SUS, a cargo da União, entre outras competências, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e de vigilância sanitária;

g. é certo que boa parte dos recursos geridos e aplicados pelo estado e pelo município na manutenção dos serviços de saúde hospitalares são oriundos do Fundo Nacional de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

Saúde e transferidos fundo a fundo aos entes subnacionais.

4. Ao longo da tramitação processual foram feitas diligências ao Ministério da Saúde (MS), ao Governo do estado do Amazonas e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH.

5. Após análise de toda a documentação aduzida aos autos, a Unidade Técnica propõe, em suma (parágrafo 61 da instrução à peça 107, p. 34-35):

a. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente;

b. determinar ao Ministério da Saúde, que, no prazo de sessenta dias, elabore plano de ação, que especifique as ações a serem tomadas, seus responsáveis e os prazos para implementação, para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, com elementos indicativos, de pelo menos, volume atual, tempo de ressuprimento, capacidade de ressuprimento do fornecedor local, tipo de fornecimento (tanques criogênicos, cilindros, usinas), consumo médio, estoque de segurança, periodicidade dessas informações, preferencialmente em sistema informatizado, para que possibilite, de forma preventiva, o controle efetivo da unidade local e o monitoramento estratégico pelo órgão de saúde nacional, enquanto perdurar a Espin [Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional]; e

c. determinar à EBSERH que, no prazo de quinze dias, apresente ao Tribunal o resultado do processo de apuração de descumprimento parcial de contrato pela empresa White Martins, pela falta de fornecimento contínuo de oxigênio, em janeiro de 2021, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV);

***

6. Diante dos elementos presentes nos autos, este representante do Parquet de Contas manifesta-se, desde já, parcialmente de acordo com a proposta de encaminhamento oferecida pela Unidade Técnica, especialmente no que se refere à existência de indícios de irregularidades que merecem maiores apurações, com a possibilidade, inclusive, de responsabilização de gestores, pelas razões a seguir expostas.

PAPEL DA UNIÃO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19 E OMISSÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

7. Afora a consabida competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de cuidado à saúde, disposta no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência específica da União o planejamento e promoção da defesa contra calamidades públicas, conforme se extrai do art. 21, inciso XVIII, da mesma Carta Política, o que não exclui a atuação concorrente dos entes subnacionais, inclusive em vista de sua estrutura operacional (redes estaduais e municipais de saúde, forças de segurança, defesa civil etc.).

8. Em matéria de saúde pública e, particularmente, de vigilância epidemiológica[1], o papel de coordenação da União é explicitado e reforçado pela Lei 8.080/1990, ao impor à direção nacional do SUS e, portanto, ao Ministério da Saúde: (i) ***a definição e coordenação do sistema de vigilância epidemiológica****; e (ii) a coordenação e a participação na execução das ações de vigilância epidemiológica (art. 16, incisos III, alínea "c", e VI, da referida lei).*

9. Por outro lado, o papel de coordenação que se impõe à União no enfrentamento da calamidade pública sanitária associada à pandemia da Covid-19 não pode constituir obstáculo ao

[1] Como vigilância epidemiológica a lei descreve "um conjunto de ações que proporcionam **o conhecimento, a detecção ou prevenção** de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de **recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos**" (art. 6º, § 2º, da Lei 8.080/1990 – grifos nossos).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

exercício, pelos entes subnacionais, de sua competência comum, em prol da melhor realização do direito à saúde, conforme ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal no referendo em medida cautelar na ADI 6341, em 15/4/2020.

10. Eventuais conflitos entre as diferentes esferas federativas na resposta à crise da Covid-19 deverão "pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas, e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde [OMS]" (trecho extraído do item 7 da ementa da mencionada decisão judicial).

11. Isso não oblitera, por óbvio, o papel de planejamento e coordenação que a Constituição impõe à União, ou lhe escusa de desempenhá-lo. Perfeita, portanto, e pouco controversa a premissa adotada pela SecexSaúde para se manifestar pela admissibilidade da presente representação:

> *15. Vê-se, portanto, que, embora as responsabilidades pela gestão e prestação de serviços de saúde na rede de média e alta complexidade do estado do Amazonas e do município de Manaus sejam, respectivamente, dos Governos do estado e do município, **a União e, consequentemente, o Ministério da Saúde, possui responsabilidade pela coordenação e supervisão do sistema**. (...) (na peça 4, p. 5, reproduzido na peça 107, p. 5, com grifos nossos)*

12. Em regulamentação da legislação sanitária em matéria de calamidade pública, o Decreto 7.616/2011, disciplina a declaração de ESPIN pelo Poder Executivo Federal, por meio de seu Ministro de Estado da Saúde.

*13. No referido decreto está estabelecido que o ato de declaração da ESPIN deve, entre outras disposições, **definir diretrizes** e medidas que nortearão o desenvolvimento das ações voltadas à solução da emergência em saúde pública e **designar representante do Ministério da Saúde responsável pela coordenação** das medidas a serem executadas (art. 10, incisos II e III).*

*14. O normativo especifica, ainda, no que consiste esse papel de coordenação, abrangendo, entre outras, as atividades de "**planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN**" e "**articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS**" (art. 10, § 1º, incisos I e II – grifos nossos).*

15. A própria Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde[2], que declarou a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional associada à pandemia da Covid-19, assim o fez, estabelecendo, em seu art. 2º, "o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública [COE-nCoV] como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional" e lhe atribuindo as competências supramencionadas.

16. Ainda que o Decreto 7.616/2011 ou mesmo a Portaria MS 188/2020 não pormenorizem as atribuições do órgão ministerial, não vislumbramos a mesma abertura semântica cogitada pela Unidade Técnica quanto às atribuições neles elencadas para propor que não se faça a audiência de agentes do Ministério da Saúde que, por suas omissões, possivelmente contribuíram para a falta de oxigênio medicinal no estado do Amazonas.

*17. Por certo, os normativos sequer poderiam antecipar todas as possíveis medidas incluídas nas atividades de planejar, organizar, coordenar e controlar, porém **o mapeamento de riscos certamente nelas se insere**. E, dada a disseminação global da doença e a extraordinária escalada dos contágios nas sucessivas "ondas de contaminação", a eventual insuficiência de recursos humanos, leitos hospitalares, equipamentos e insumos, associada a dificuldades em sua rápida obtenção, é um **risco antecipado desde o início da pandemia**, sendo esperado que o Ministério da Saúde, como agente coordenador do enfrentamento da calamidade pública sanitária associada à pandemia da Covid-19, empreendesse medidas de resposta eficazes, evitando a materialização do risco, ou ao menos reduzindo o seu impacto, em face da alta probabilidade de ocorrência.*

[2] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388> – acesso em 23/2/2022.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

18. O próprio "Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19", elaborado pelo COE-Covid-19, trazia, já em sua primeira versão, de fevereiro de 2020, dentre as medidas pertinentes, (i) a avaliação de risco, (ii) levantamento da disponibilidade e apoio à ampliação de leitos, (ii) a garantia do estoque estratégico de medicamentos e o monitoramento do estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual, (iii) a revisão e o estabelecimento de logística de controle, distribuição e remanejamentos (peça 52 do TC 014.575/2020-5).

19. Inclusive, em junho de 2020, a OMS já alertava para o risco de falta de oxigênio medicinal em meio a ondas de contaminação[3], conforme apontado no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Federal (CPI da Pandemia), conforme se verificou, pouco depois, em país vizinho[4] (peça 111, p. 286).

20. Ainda que se possa qualificar a falta de oxigênio medicinal ocorrida no estado do Amazonas como uma situação "inusitada e extraordinária" – tal como fez a Unidade Técnica –, tais características, em um contexto maior igualmente "inusitado e extraordinário", como é a pandemia da Covid-19, não podem servir de fundamento para a escusa de agentes públicos que, eventualmente, tenham contribuído para a ocorrência de evento danoso por meio de suas omissões. Do contrário, teríamos que admitir qualquer resultado em termos de resposta à crise sanitária, o que não se mostra razoável.

21. É certo que as circunstâncias importam, porém, deve ser exigido da gestão pública o aperfeiçoamento da resposta ao longo da pandemia, sobretudo quando já haviam se passado dez meses desde a declaração da ESPIN, em fevereiro de 2020.

22. O que importa, nesse contexto, é a eventual imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento danoso. Porém, o desabastecimento de oxigênio ocorrido no estado do Amazonas ***não pode ser caracterizado como evento imprevisível e/ou inevitável****, tratando-se de um risco conhecido e mitigável, vale dizer, passível de ser tratado (no exercício das competências inerentes ao planejamento, à organização, à coordenação e ao controle das medidas a serem empregadas durante a ESPIN, a teor do art. 10, § 1º, inciso I, do Decreto 7.616/2011), por meio de providências que buscassem oferecer respostas alternativas, no sentido de prevenir a sua ocorrência ou de reduzir os seus impactos, especialmente no que se refere ao estado do Amazonas e, particularmente, à cidade de Manaus, onde, havia alguns meses, constatara-se um primeiro colapso do sistema de saúde (abril de 2020), na primeira onda de contágio que se deu no local[5].*

23. Trata-se, ainda, de uma cidade bastante peculiar, por seus mais de dois milhões de habitantes e seu relativo isolamento geográfico, distante de outros grandes centros, com poucas conexões rodoviárias e para a qual o transporte de cargas se faz principalmente pela via rodofluvial e mediante viagens longas. O transporte aéreo de carga, para aquela localidade, apesar de possível, enfrenta limitações de volume, agravadas por exigências de segurança associadas ao produto transportado, por sua alta inflamabilidade. Essa peculiaridade e suas implicações em termos de gestão de riscos foram bem exploradas pela SecexSaúde na instrução de peça 107:

> *36.18. O que não se admite, especialmente no meio de uma pandemia, é a falta de controle do consumo de insumos e medicamentos pelos entes subnacionais, e falta de informações para subsidiar a coordenação e o monitoramento dos insumos e medicamentos estratégicos pelo Ministério da Saúde, bem como o órgão ministerial não buscar essas informações.* ***A atuação preventiva exige o controle e a disponibilização de informações sobre a execução das ações em***

[3] Disponível em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---24-june-2020> e <https://www.poder360.com.br/internacional/oms-alerta-para-falta-de-oxigenio-no-tratamento-da-covid-19> – acessos em 23/2/2022.

[4] Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/07/29/familias-desesperadas-passam-horas-atras-de-oxigenio-em-mercado-paralelo-no-peru.htm> – acesso em 23/2/2022.

[5] Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/22/colapso-na-saude-e-enterros-em-valas-coletivas-em-manaus-assustam-senadores> – acesso em 23/2/2022.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

> ***saúde, considerando a dificuldade na obtenção de insumos e medicamentos em prazos e quantidades necessários para atender a demanda, principalmente em localidades onde a logística exige maior tempo e estrutura multimodal para cumprir o tempo de ressuprimento, como ocorre no estado do Amazonas****. (peça 107, p. 18-19) (grifos nossos)*

24. De forma muito semelhante discorreu o Relatório Final da CPI da Pandemia (peça 111, p. 285-286):

> ***O monitoramento da situação mostra-se ainda mais necessário em vista das dificuldades logísticas presentes na Região Norte do País****, que dificultam o transporte de grande quantidade desses insumos médicos a partir de outras regiões em um curto espaço de tempo. Avaliação da White Martins, realizada em fevereiro de 2021, previu que o itinerário para transporte de oxigênio a partir da planta da empresa em Belém (Planta de Barcarena), por meio de balsa (ponte fluvial), tem a duração de treze dias.*
>
> *A esse período se somam cinco dias, caso o produto seja originário da Planta de Ourilândia do Norte/PA; quatro dias, caso o produto seja originário de Imperatriz/MA (empresa Air Liquide) ou Açailândia/MA (empresa AVB); e seis dias, caso o produto seja originário da Planta de PECEM, em São Gonçalo do Amarante/CE. Além do uso da via fluvial, por Belém/PA, a companhia concluiu ser possível o fornecimento a partir da Venezuela (empresa Invegas, do mesmo grupo da White Martins), em rota de sete dias, ou a partir de Brasília, por via aérea. (grifos nossos)*

25. Porém, a União, por seu Ministério da Saúde, optou por negligenciar o desempenho do papel de coordenação que constitucional e legalmente lhe incumbia. Essa constatação é bem evidenciada no controle pari passu levado a efeito pelo TCU da atuação do Governo Federal e de seu Ministério da Saúde no enfrentamento à crise pandêmica, onde sucessivos alertas foram feitos pelo Tribunal, inclusive sob a forma de determinações reiteradas.

26. No Acórdão 1.616/2020-Plenário, de 24/6/2020, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, proferido no TC 016.708/2020-2, o TCU já apontava a ausência de planejamento e coordenação federal no enfrentamento da pandemia, conforme se extrai do trecho de seu relatório reproduzido a seguir:

> *57. A ausência de uma diretriz estratégica clara de enfrentamento ao novo coronavírus no país, com objetivos estabelecidos, a ser comunicada e implementada a nível nacional, em articulação com os demais entes federados, prejudica a efetividade das ações de coordenação, articulação, supervisão e monitoramento dos resultados e impactos das ações implantadas, além de ocasionar desperdício de recursos humanos e financeiros.*
>
> *58. Ainda que caiba a prefeitos e governadores estabelecerem parte das medidas para o enfrentamento ao coronavírus, nos respectivos entes federados, cabe ao CG [Centro de Governo] o papel de propor diretrizes estratégicas e os objetivos a serem atingidos, bem como articular e coordenar sua implantação com os demais órgãos e entidades da administração pública nos três níveis.*
>
> *59. A dimensão do país, bem como as variações socioeconômicas, sanitárias, de densidade populacional e até mesmo culturais entre as diversas regiões do país devem ser consideradas ao estabelecer diretrizes estratégicas efetivas de combate à epidemia do novo coronavírus, assim como na implantação [da] política pública. (...)*
>
> *60. Sem diretrizes claras de como será feito o combate à doença no país, **o CG assume postura meramente reativa diante da pandemia, organizando-se prioritariamente para atender demandas**. (...) (grifos nossos)*

*27. De tal constatação decorreu **alerta à Casa Civil** de que "**a ausência de diretriz estratégica clara de enfrentamento à Covid-19, com a respectiva gestão de riscos**, bem como a ausência de um plano de comunicação coordenado e abrangente, **pode comprometer os gastos e os resultados** do enfrentamento à pandemia e **impedir uma efetiva coordenação política e articulação entre órgãos e entidades, federais e subnacionais**" (subitem 9.1 do Acórdão 1.616/2020-Plenário) (grifos nossos).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

28. Pouco tempo depois, no bojo do TC 014.575/2020-5 – acompanhamento das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde (inclusive órgãos e entidades vinculados) para o combate à crise gerada pelo coronavírus (covid-19) – o Tribunal proferiu o Acórdão 1.888/2020-Plenário, de 22/7/2020, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler (pertinente ao segundo relatório de acompanhamento produzido naqueles autos), do qual constaram, dentre outros encaminhamentos, determinações ao Ministério da Saúde para:

*i) a adequação do funcionamento do COE-nCoV "aos normativos de regência de sua atuação, **reforçando o seu papel de articulação e coordenação no enfrentamento da pandemia**, nos termos da Portaria GM/MS 188/2020" (subitem 9.1.1) (grifos nossos), além de outras medidas de aperfeiçoamento e adequação da governança de combate à crise do coronavírus; e*

ii) a elaboração de "plano tático-operacional detalhado" para viabilizar a implementação das medidas do Plano de Contingência Nacional assim especificadas (subitem 9.1.5):

a) promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus SARS-COV-2;

b) garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus;

c) garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS- COV-2;

d) garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção humana pelo novo coronavírus, junto a rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios;

e) garantir os insumos para diagnóstico pela infecção humana pelo novo coronavírus e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial;

f) garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes;

g) garantir medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico; monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual;

h) estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação e demanda

i) apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou contratação de leitos com isolamento dos casos de SG, SRAG e da infecção humana pelo novo coronavírus;

(...)

(Letras "a" a "i" constantes do parágrafo 60 da instrução da SecexSaúde à peça 86 do TC 014.575/2020-5, p. 10)

29. No relatório de acompanhamento seguinte produzido no TC 014.575/2020-5 (terceiro relatório), aprovado pelo Acórdão 2.817/2020-Plenário, de 21/10/2020, consignou-se que as evidências até ali colhidas não demonstravam o cumprimento das determinações acima (subitens 9.1.1 e 9.1.5 do Acórdão 1.818/2020-Plenário).

*30. Na deliberação, optou-se pelo reforço da última daquelas determinações, em termos semelhantes, **justamente diante da possibilidade de "um eventual recrudescimento de casos, caraterizado como uma segunda onda**, tal qual atualmente verificado em alguns países europeus", sobre o qual alertava o Ministro Relator, Benjamin Zymler (vide parágrafo 71 do voto condutor do Acórdão 2.817/2020-Plenário).*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

31. A nova determinação figurou no Acórdão 2.817/2020-Plenário nos seguintes termos:

> *9.1. **determinar ao Ministério da Saúde**, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação:*
>
> *(...)*
>
> *9.1.2. nos termos do art. 16, inciso VI, da Lei 8.080/1990, elabore plano estratégico detalhado para a viabilização, em especial, das seguintes medidas de gestão e assistência farmacêutica previstas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (nível de resposta Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional):*
>
> *9.1.2.1. garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19;*
>
> *9.1.2.2. garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS-COV-2;*
>
> *9.1.2.3. monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual;*
>
> *9.1.2.4 rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda;*
>
> *9.1.2.5. garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.*

*32. Também se determinou, no Acórdão 2.817/2020-Plenário, a elaboração de "**política de testagem** da Covid-19", estabelecendo, em especial, a quantidade de testes a serem adquiridos, o público alvo, o prazo para o atendimento, a frequência dos testes a serem aplicados aos integrantes do público alvo e os critérios para distribuição de testes entre os entes subnacionais" (subitem 9.1.3) (grifos nossos), por se tratar de importante mecanismo de monitoramento do comportamento da pandemia e de antecipação dos impactos de seus episódios de agravamento (incluso aí, por certo, o desabastecimento de insumos estratégicos para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus).*

*33. Em face das determinações mencionadas, o Ministério da Saúde optou, porém – nas palavras da equipe do TCU, constantes do quarto relatório de acompanhamento elaborado no TC 014.575/2020-5, aprovado pelo Acórdão 4.049/2020-Plenário, de 8/12/2020 –, "por adequar o normativo de regência do COE [COE-nCoV] ao papel efetivamente desempenhado pelo mecanismo" (parágrafo 41 do relatório), ao invés da adequação do seu funcionamento aos normativos de regência. Na mesma linha, o Ministério sinalizou a intenção de rever o Plano de Contingência Nacional, **inclusive com a supressão da atribuição de garantia do estoque estratégico de medicamentos**.*

*34. Esquivava-se, portanto, o Ministério da Saúde de seu papel de planejamento e coordenação, tão importante – como bem consignado no quarto relatório de acompanhamento – **para "minimizar riscos de desabastecimento**, de perda de produtos por expiração de prazo de validade, de aquisição de materiais desnecessários ou em quantidades superiores às necessárias" (parágrafo 45 do relatório do Acórdão 4.049/2020-Plenário). Frisou-se, ainda, tratarem-se de **"riscos sobre os quais o TCU tem alertado o Ministério da Saúde** desde o início do presente acompanhamento, com o envio de inventário de riscos, mencionado no primeiro e segundo relatórios de fiscalização" (parágrafo 45 do relatório do Acórdão 4.049/2020-Plenário – grifos nossos).*

35. A atitude eminentemente reativa do Governo Federal e particularmente do Ministério da Saúde já havia sido apontada pelo TCU no supramencionado Acórdão 1.616/2020-Plenário e foi verificada, também, no episódio ora tratado, como bem explicitou a Unidade Técnica:

> *36.4. **Na crise do oxigênio em Manaus, o Ministério da Saúde teve um papel reativo**, buscando mitigar, quando informado pelo governo do estado do Amazonas, soluções junto ao Ministério da Defesa para transporte de cilindros de oxigênio de outros pontos do território nacional, bem como da Ebserh, para transferência e acolhimento de pacientes. (instrução à peça 107, p. 17 – grifos*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

nossos)

36. Aqui convém rebater mais um dos fundamentos utilizados pela Unidade Técnica para a escusa dos agentes do Ministério da Saúde: o de que inexistiria, desde o início da pandemia, uma sistemática de monitoramento da disponibilidade de oxigênio medicinal, por meio de informações prestadas pelos entes subnacionais e deles exigida (peça 107, parágrafo 36.23).

37. A premissa, com as devidas vênias, desconsidera a necessidade de constante aperfeiçoamento do planejamento e da coordenação federal, bem assim da troca de informações (articulações) entre as esferas central e subnacional, da identificação e do tratamento de riscos, no curso do enfrentamento da pandemia, como, aliás, prescreviam, de forma expressa, os incisos I e II do art. 3º da Portaria MS 188/2020. Falhas que no início da pandemia seriam compreensíveis e releváveis, pelo desconhecimento do vírus e pela rapidez com a qual ele se alastrou, com o passar do tempo deixavam de sê-lo, em vista das experiências internacionais e nacional – ou das diversas experiências regionais – acumuladas. Desconsidera, ainda, a recalcitrância do Ministério da Saúde frente à sucessão de alertas emanados desse tribunal. E não só dele, mas de outras instituições – inclusa a OMS[6] –, bem como de especialistas e entidades especializadas da sociedade civil.

38. Ainda que a aquisição do oxigênio medicinal, o mapeamento de possíveis fornecedores e o monitoramento de sua capacidade de atendimento frente a episódios antecipáveis de elevação da demanda sejam obrigações primárias dos entes subnacionais contratantes, em um contexto de calamidade pública sanitária de extensão nacional – até mesmo em vista do arcabouço jurídico aqui invocado – , não se pode admitir, como bem frisou a Unidade Técnica, a ausência de monitoramento por parte do Ministério da Saúde, no exercício de seu papel de planejamento e coordenação.

39. Mesmo porque, em caso de materialização do risco, ou seja, em caso de concretização do quadro de desabastecimento, sem que haja solução rápida ao alcance dos gestores locais, é a União a responsável por remediar a situação – com os altos custos que situações emergenciais comumente impõem –, dentro de um contexto de federalismo cooperativo, em que vigora a competência comum dos entes federados em matéria de saúde (Constituição Federal, art. 23, inciso II) e o protagonismo do ente central no enfrentamento a calamidades públicas (Constituição Federal, art. 21, inciso XVIII). Inclusive, no episódio do estado de Amazonas ora tratado, o desfecho disso não diferiu.

40. Portanto, o eventual desabastecimento de insumos relevantes, ainda que em âmbito local, não deixa de ser uma contingência federal, além de risco concreto no contexto de pandemia, exigindo do Poder Executivo Federal esforços preventivos, o que envolve avaliação de risco, especialmente por meio de monitoramentos de estoque, de oferta e de demanda, além da prévia definição de planos de contingência, para o remanejamento desses insumos no território nacional e, em casos extremos, para a remoção de pacientes.

A SUCESSÃO DE ACONTECIMENTOS QUE CULMINARAM NA FALTA DE OXIGÊNIO E O NEXO CAUSAL ENTRE AS OMISSÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O EVENTO DANOSO

41. Diversos são os fatos que permitem concluir pela previsibilidade do desabastecimento de oxigênio medicinal no estado do Amazonas durante a onda de contaminação ocorrida entre o final de 2020 e o início de 2021, e pelo nexo causal entre a conduta omissiva das autoridades federais e a concretização do evento danoso.

42. Conforme registrou a Unidade Técnica, o quadro de elevação de casos e o alarmante aumento da ocupação de leitos hospitalares era conhecido do governo estadual (peça 107, p. 17, parágrafo 36.6), mas não só dele. Em 27/12/2020, o portal G1 já noticiava um aumento de internações por Covid-19 de 28% entre novembro e dezembro em Manaus, com 88 novos registros de internação por Covid-19 em um único dia – número equivalente àqueles observados em maio daquele

[6] Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/oms-pede-que-brasil-leve-covid-19-a-sério/a-55779089> – acesso em 23/2/2022.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

mesmo ano, quando o estado do Amazonas viveu seu primeiro colapso do sistema público de saúde. A taxa de ocupação do hospital de referência para o tratamento da doença na cidade estaria próxima de 100%[7]. Em 29/12/2020, já eram 112 novas internações, recorde até então[8].

43. Evidentemente, o expressivo aumento no número de internações foi precedido de semelhante aumento no número de contaminações[9], não necessariamente registrado por meio de testagem, em razão da notória insuficiência de testes e da ausência de uma política nacional de testagem, estruturada e coordenada pelo Ministério da Saúde (vide determinação do TCU ao Ministério da Saúde, no subitem 9.1.3 do Acórdão 2.817/2020-Plenário, para a elaboração de "política de testagem da Covid-19").

44. A fim de conferir resposta efetiva ao risco (de alta probabilidade e de alto impacto) de desabastecimento de insumo estratégico para o combate da pandemia, o Poder Público dispõe, porém, de outros instrumentos para a identificação do aumento de casos, a exemplo do índice de positivação de testes, que poderiam ter auxiliado na identificação precoce da gravidade do quadro que se avizinhava.

45. De qualquer modo, os dados disponíveis do fim do mês de dezembro indicavam preocupante progressão das contaminações, os quais já eram de conhecimento do Poder Público estadual, pelo menos, desde 23/12/2020, quando foi editado o Decreto Estadual 43.234, que estabeleceu o fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e destinados a recreação e lazer entre 26/12/2020 e 10/1/2021, além de outras medidas restritivas[10].

46. Não obstante, o decreto foi revogado logo em seguida, em 27/12/2020, em virtude de manifestações populares contrárias, conforme notícia apresentada no Relatório Final da CPI da Pandemia (peça 111, p. 262-263).

47. O mesmo relatório registra que os dados da vigilância sanitária amazonense (da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas) são integrados ao Datasus, o que permitia o acompanhamento pelo Ministério da Saúde[11] da evolução da pandemia no Estado (relatório suprarreferido, p. 263). É o que evidencia, ainda, o "Plano Manaus" (peça 113), elaborado pelo Ministério da Saúde em 06/01/2021.

48. Segundo o documento, o Ministério acompanhava a evolução do quadro de Manaus, tendo sido realizada reunião em Brasília a respeito do tema em 28/12/2020:

> *Este Ministério, acompanhando o número de hospitalizações motivadas pela Covid-19 em Manaus, AM, **observou, naquele Município, um aumento de casos a partir já da semana do Natal de 2020, com significativo aumento a partir de 27 de dezembro, quando o número de hospitalizações dobrou, em relação à semana anterior** (36 casos em 20 de dezembro, versus 88 casos, em 27 de dezembro) (https://localizasus.saude.gov.br/).*
>
> ***Em 28 de dezembro, o Ministro da Saúde reuniu seu secretariado e principais assessores para tratar do tema e planejar ações compatíveis com essa evolução das hospitalizações**. Decidiu-se, então, pelo envio, a Manaus, de um dos secretários, formado em medicina, para avaliar a situação logo após a virada do ano. Escolheu-se, para a tarefa, a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro. Decidiu-se por realizar a viagem apenas após o ano novo, em virtude do início de mandato de gestores municipais e de possíveis trocas de secretariado.*

---

[7] Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/27/com-88-registros-de-internacoes-por-covid-19-nas-ultimas-24h-manaus-tem-recorde-de-novos-hospitalizados.ghtml> – acesso em 23/2/2022.

[8] Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/29/manaus-bate-recorde-de-internacoes-por-covid-19-desde-inicio-da-pandemia.ghtml> – acesso em 23/2/2022.

[9] Ver "Boletim Situação Epidemiológica de COVID-19 e da Síndrome Respiratória Aguda Grave no Estado do Amazonas" (p. 3-4 – disponível em: <https://www.fvs.am.gov.br/media/publicacao/boletim_covid_16.pdf> – acesso 23/2/2022.

[10] Disponível em: <https://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202020/DE%2043.234_20.htm> – acesso 23/2/2022.

[11] Via LocalizaSus, acessível no seguinte endereço: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/demas/localizasus> – acesso 23/2/2022.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

(peça 113, p. 2)

49. Por meio de ofício datado de 30/12/2020 (Ofício 6672/2020 – peça 98), a Secretaria de Saúde do Amazonas solicitou ao Ministério o envio da Força Nacional do SUS para auxílio "no monitoramento, orientação técnica, bem como operação local de suporte básico e avançado no atendimento à população que busca atendimento em Unidades de Saúde" (peça 98, p. 2).

50. A equipe do Ministério da Saúde chegou ao Estado somente em 03/1/2021, conforme deliberado naquela reunião de 28/12/2020. Naquele momento, as internações haviam novamente dobrado em uma semana[12] e as mortes se encontravam em escalada. A média móvel de mortes dos 7 dias anteriores se mostrava mais de três vezes maior que a verificada quando da reunião ocorrida no ministério[13].

51. Em 04/1/2021, houve uma reunião entre a equipe do Ministério da Saúde, os chefes dos Poderes Executivos e Secretários de Saúde do Estado do Amazonas e do Município de Manaus, na qual ficou registrada a ***possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias****, ou seja, por volta do dia 14/1/2021, justamente quando ocorreu o desabastecimento:*

> *As principais conclusões desse encontro e da viagem de reconhecimento a Manaus foram:*
>
> *- há possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde, em 10 dias, devido à falta de recursos humanos para o funcionamento dos novos leitos;*
>
> *- há deficiência na resolutividade da atenção primária, por não estarem utilizando as orientações de intervenção precoce para Covid-19, conforme orientações do MS;*
>
> *- há dificuldades na aquisição de materiais de consumo hospitalar, medicamentos e equipamentos;*
>
> *- há dificuldades na contratação de profissionais com habilitação para atuação nas UTIs;*
>
> *- há necessidade de estruturação de leitos de UTI com celeridade para atendimento aos pacientes que já demandam internação, constatada pela alta ocupação dos leitos dos serviços de urgência e emergência (salas rosas e vermelhas)*
>
> *- taxa de ocupação atual de 89,1%; e*
>
> *- estima-se um substancial aumento de casos, o que pode provocar aumento da pressão sobre o sistema, entre o período de 11 a 15 de janeiro, em função das festividades de Natal e réveillon. (peça 113, p. 3)*

52. Diante da constatação da escalada de casos e internações e da iminência de colapso do sistema de saúde, um óbvio questionamento a ser feito seria quanto aos estoques e capacidade de fornecimento de insumos essenciais, em vista das projeções de aumento nas internações. Especialmente em se considerando os obstáculos logísticos, aqui já comentados, ao ressuprimento de oxigênio medicinal. Porém, ao que tudo indica, o questionamento não foi feito, nem pelas autoridades estaduais à empresa fornecedora, nem pelo Ministério da Saúde.

53. O Ministério aparentemente se furtou de coordenar o monitoramento dos riscos de desabastecimento, permanecendo, nesse ponto, em sua posição reativa, de atuação sob demanda, mesmo diante da ciência do iminente colapso.

54. Esperou-se que a empresa fornecedora de oxigênio, a White Martins, constatasse, por si só, sua incapacidade de atender à demanda, vertiginosamente crescente e persistente em virtude de um número de internações igualmente crescente e persistente, sem que necessariamente detivesse informações epidemiológicas para prever o momento do desabastecimento ou competência – técnica e

[12] "... 36 casos em 20 de dezembro, versus 88 casos, em 27 de dezembro... No dia 3 de janeiro de 2021, data da chegada da comitiva do Ministério a Manaus, o número de hospitalizações motivadas pela Covid-19 em Manaus voltou a dobrar (159 casos)." (peça 113, p. 2).
[13] Disponível em: <https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/manaus-am/> – acesso 23/2/2022.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

jurídica – para fazê-lo.

55. Porém, cabia, evidentemente, ao Poder Público – federal e estadual – a reunião e análise dos dados epidemiológicos e a realização de projeções, inclusive com a estimação da demanda por insumos.

56. Mesmo diante dos primeiros sinais de dificuldade de fornecimento por parte da White Martins, em 7/1/2021, obtidos pelas autoridades estaduais e compartilhados com o Ministro da Saúde (peça 107, parágrafos 39.1 e 39.2), nenhuma providência preventiva específica foi adotada.

57. O governo do Estado limitou-se a buscar, no que se refere à questão do oxigênio medicinal, com apoio do governo federal, complementação pontual da oferta do gás, no montante indicado pela empresa, que não tinha – repisa-se – a obrigação legal, nem necessariamente os meios e a expertise para estimar a tendência da demanda. É o que se pode constatar da leitura da Tabela 2 – Cronologia dos Eventos da Falta de Oxigênio (peça 107, p. 29-31).

58. Ainda nesse aspecto, a Unidade Técnica ressalta (peça 107, parágrafo 45.9, p. 31) que era do conhecimento do governo estadual a crescente demanda por oxigênio medicinal, que se manifestou por meio de pedidos sucessivos de aditivos contratuais por parte da empresa contratada, que solicitara aditivo de, aproximadamente, 47%, pois o percentual de aproximadamente 22% não atenderia a demanda até dezembro/2020.

*59. Conforme quadro contido na peça 107, p. 29, no dia 23/11/2020, foi assinado o 7° Termo Aditivo ao Contrato 61/2016, o qual teve como origem expediente oriundo da própria empresa White Martins (peça 96, p. 1-2), protocolado junto à Secretaria Estadual de Saúde em 16/7/2020, que requereu aditivo contratual de 25% em razão do **excesso de consumo nos meses de abril a maio/2020**, que consumiu mais do que a cota mensal planejada para o contrato, de modo que o valor total do contrato seria atingido meses antes do término do seu ciclo anual de doze meses.*

60. No referido documento da empresa fornecedora, essa já sinalizava estar no limite de sua capacidade produtiva e noticiava o aumento exponencial da demanda nas redes pública e privada.

61. Em 11/9/2020, dois meses aproximadamente após o protocolo do ofício da White Martins acima mencionado, técnico da Secretaria Estadual de Saúde estima ser necessário dobrar praticamente o percentual de aditivação contratual para atender a demanda (peça 96, p. 64).

*62. Caso a União tivesse atendido todos os alertas expedidos por este Tribunal, e criado sistema de monitoramento dos insumos estratégicos usados no tratamento da doença, dentre eles o oxigênio medicinal, a inércia estadual diante dos evidentes sinais de aumento de seu consumo, verificados desde **abril de 2020**, poderia ter sido identificada e remediada por meio de medidas preventivas e corretivas da parte da União que pudessem evitar o grave desabastecimento verificado.*

*63. O Relatório Final da CPI da Pandemia indica a data de 10/1/2021 como momento em que a União e o estado do Amazonas passaram a adotar providências mais relevantes para evitar eventual desabastecimento de oxigênio medicinal, **porém ainda tímidas**: o Governador do Estado teria encaminhado, naquela data, ofícios a todos os outros Governadores, solicitando a disponibilização de estoque de oxigênio, e o governo federal teria iniciado o contato com cinco grandes fornecedores do produto no Brasil (Air Products, Messer, IBG e Air Liquide) (peça 111, p. 297).*

64. Isso supostamente depois das possíveis primeiras notícias de insuficiência do abastecimento de oxigênio na rede hospitalar local, entre os dias 8 e 9/1/2021, conforme evidencia o seguinte trecho do referido relatório (peças 111, p. 266-268; 112, p.179-180):

> *Relatos de reuniões e vistorias da Força Nacional do SUS, nos primeiros dias de 2021, já apontavam para a gravidade da situação. Reunião do dia 8 de janeiro de 2021 teve seu foco alterado "pois foi relatado um colapso dos hospitais e falta da rede de oxigênio" (Anexo ao Doc 855 – Requerimento 10/2021):*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

- Estão preferindo não medir a saturação dos pacientes na sala rosa 1, pois, ao medir, vários pacientes precisarão de oxigênio e não terão como suprir a demanda.

- Os médicos estão decidindo quais pacientes entubar, quais ficarão no cuidado paliativo, quais pacientes podem ficar sem suporte semi-intensivo, ou na sala vermelha entubados ou VNI, pois a demanda está muito maior que a capacidade instalada da unidade.

65. Não há notícia, por outro lado, da consideração, pelo governo federal, da importação emergencial do produto, que, por questões logísticas, talvez pudesse ser transportado em larga escala e em menor tempo da Venezuela (sete dias de trânsito, segundo informação da White Martins) – peça 111, p. 286.

66. O relatório em questão traz, ainda, informação prestada pelo ex-Secretário Executivo do Ministério da Saúde, o Sr. Antônio Elcio Franco Filho, em depoimento à CPI, de que o Ministro da Saúde teria se reunido com a White Martins no dia 11/1/2021, após o que teria havido, já no dia seguinte, 12/1/2021, suprimento de oxigênio líquido por meio de aeronave da FAB (peça 111, p. 268).

67. Não se sabe, no entanto, a veracidade da informação, nem maiores detalhes, a exemplo de eventual dimensionamento da demanda em vista dos dados epidemiológicos, a quantidade transportada, se a providência era tida ou não como suficiente, se medidas complementares já eram consideradas e por que não se iniciaram ali outras medidas, a exemplo da remoção de pacientes.

68. O relatório final da CPI da Pandemia dá conta ainda de que a transferência de pacientes foi cogitada no dia 12/1/2021, em reunião do Comitê de Crise constituído entre as esferas federativas. Porém, não teria havido decisão pela imediata execução (peça 111, p. 305).

69. Somente na véspera do episódio de desabastecimento, depois de alertadas pela empresa fornecedora, as autoridades envolvidas deram início ao que a Secretaria de Saúde do estado do Amazonas chamou de "plano emergencial de evacuação" de pacientes internados na rede pública de saúde para outros estados da federação. O que se deu foi uma ação de remoção voluntária de pacientes, na madrugada do dia 14.01.2021, frustrada pela desistência "de última hora" de todos os pacientes triados (peça 107, parágrafos 39.14 e 39.15).

70. Novo voo teria sido reagendado para as 6h da manhã do dia 15.01.2021, para o qual contaram com concordância de apenas 9 pacientes (peça 107, parágrafo 39.16), o que resultou em mais um esforço frustrado, quando já instalado o dramático quadro de falta de oxigênio medicinal em Manaus.

*71. Tal sucessão de fatos reforça o acerto da conclusão da Unidade Técnica de que o Ministério da Saúde não exerceu "o seu papel de coordenador dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária [art. 16 da Lei 8.080/1990], transferindo recursos, **sem possuir e exercer papel proativo para evitar ou mitigar situações que escapam do controle da direção estadual do SUS**" (peça 107, parágrafo 36.11), e, nesse sentido, contribuiu para a ocorrência do evento e suas respectivas consequências para a saúde da população.*

*72. Vale mencionar, ainda, que, em resposta à sinalização da Unidade Técnica quanto a uma possível determinação para que o Ministério da Saúde elaborasse um plano de ação para o monitoramento do abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, **o órgão reiterou o entendimento de que "o controle e monitoramento do consumo do oxigênio medicinal deve ser feito pelos entes subnacionais"** e que a ele só caberia **"prestar apoio, quando fosse demandado"** (peça 107, parágrafo 36.29) (grifos nossos).*

73. Isso a despeito do papel constitucional e legal da União em caso de calamidade pública e apesar do risco elevado que tal postura atrai frente à excepcionalidade do quadro pandêmico, conforme infelizmente se pôde constatar na prática, frente ao desfecho do caso do estado do

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

Amazonas.

CONCLUSÃO

74. Diante do exposto, este representante do Parquet de Contas considera que a gravidade dos fatos demanda a realização de audiência de gestores federais em decorrência dos eventos tratados neste processo.

75. Os elementos e evidências contidos nos autos apontam para a existência de indícios de irregularidades atribuíveis ao então Ministro da Saúde à época, pois, apesar dos reiterados alertas proferidos pelo TCU, deixou de adotar medidas estratégicas para a coordenação e alinhamento das diversas iniciativas e ações do Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia no estado do Amazonas, as quais deveriam ter sido tomadas e conduzidas pelo representante da pasta ministerial, caracterizando o descumprimento de seu papel institucional de governança na condição de coordenador dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, conforme preceitua o art. 16 da Lei 8.080/1990 c/c art. 200, incisos I e II, da Constituição Federal. Além disso, verificou-se omissão do Ministro da Saúde à época das ocorrências examinadas neste processo quanto ao exercício de competências afetas ao correspondente ministério, previstas nos seguintes incisos do art. 47 da Lei 13.844/2019, a seguir transcritos:

> *Art. 47. Constituem **áreas de competência do Ministério da Saúde**:*
>
> *I - política nacional de saúde;*
>
> *II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;*
>
> *(...)*
>
> *IV - **informações de saúde**;*
>
> *V - **insumos críticos para a saúde**;*
>
> *(...) (grifos nossos)*

76. Como registrado pela Unidade Técnica, a inércia e omissão do Ministério da Saúde contribuíram para falta de oxigênio no estado do Amazonas e suas respectivas consequências para a saúde da população.

77. O titular da ministério à época do ocorrido em Manaus era o então Ministro Eduardo Pazuello, que ocupou a pasta de 15 de maio de 2020 a 15 de março de 2021, período em que as determinações e recomendações contidas nos acórdãos do TCU citados neste parecer foram exaradas (Acórdãos 1.616/2020-Plenário, de 24/6/2020; 1.888/2020-Plenário, de 22/7/2020; 2.817/2020-Plenário, de 21/10/2020; 4.049/2020, de 08/12/2020).

78. Além do então titular da Pasta da Saúde, os então Secretários da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS), Luiz Otávio Franco Duarte, nomeado em 26/5/2020[14], exonerado em 12/4/2021[15], e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde (SCITE), Hélio Angotti Neto, nomeado em 17/6/2020[16], ocupando o cargo até a atualidade, devem também ser chamados a integrar o presente feito, por meio das devidas audiências, a fim de que possam, igualmente, trazer aos autos razões de justificativa para a omissão em adotar medidas com vistas à implantação de sistema nacional de monitoramento de insumos críticos para uso no tratamento de pacientes com Covid-19, contribuindo para o agravamento da crise de abastecimento de oxigênio medicinal na cidade de Manaus/AM, em janeiro de 2021, apesar dos reiterados alertas proferidos pelo TCU para a adoção de medidas estratégicas de coordenação e de planejamento, junto aos entes subnacionais, das diversas iniciativas e ações a cargo do Ministério da Saúde para enfrentamento da

[14] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-26-de-maio-de-2020-258714336
[15] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-12-de-abril-de-2021-313497004
[16] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-312-de-17-de-junho-de-2020-262156564

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

pandemia, incluindo o monitoramento de insumos críticos, considerando a existência de sinais claros de demanda crescente dos insumos no estado do Amazonas, especialmente em Manaus, desde abril de 2020, em descumprimento do papel institucional de governança daquele Ministério, na condição de coordenador dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, conforme preceitua o art. 16, incisos III, alíneas "c" e "d", VI, X, XII, XIII, XIV e parágrafo único vigente à época (hoje renumerado como § 1º), da Lei 8.080/1990 c/c os arts. 21, inciso XVIII, 23, inciso II, 200, incisos I e II, da Constituição Federal; art. 47, incisos II, IV e V, da Lei 13.844/2019; e art. 10, § 1º, inciso I, do Decreto 7.616, de 17 de novembro de 2011.

79. A audiência dos titulares das secretarias acima mencionadas se deve ao fato de possuírem entre suas atribuições o aperfeiçoamento da capacidade de gestão dos serviços de saúde, ações emergenciais em saúde, ações de regulação do mercado, entre outras que podem se relacionar ao monitoramento de insumos estratégicos em saúde.

80. As competências da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS) estão definidas no art. 22, do Decreto 9.795/2019:

> *Art. 22. À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde compete:*
>
> *I - participar da formulação e da implementação da política de atenção especializada à saúde, observados os princípios e as diretrizes do SUS;*
>
> *II - definir e coordenar sistemas de redes integradas de ações e serviços de atenção especializada à saúde;*
>
> *III - estabelecer normas, critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade e para a avaliação da atenção especializada à saúde;*
>
> *IV - identificar os serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos de atenção especializada à saúde;*
>
> *V - elaborar e propor normas para disciplinar as relações entre as instâncias gestoras do SUS e os serviços privados contratados de assistência especializada à saúde;*
>
> ***VI - avaliar, em âmbito nacional, as ações de atenção especializada à saúde**;*
>
> ***VII - prestar cooperação técnica para o aperfeiçoamento da capacidade gerencial e operacional da atenção especializada à saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;***
>
> *VIII - coordenar a formulação e a implementação da política de regulação assistencial do SUS;*
>
> ***IX - participar da elaboração, da implantação e da implementação de normas, instrumentos e métodos que fortaleçam a capacidade de gestão do SUS nas três esferas de governo no âmbito da atenção especializada à saúde;***
>
> *(...)*
>
> ***XI - propor normatização ao Ministro de Estado acerca das ações e dos serviços de atenção especializada à saúde no âmbito do SUS e estabelecer normas complementares necessárias à implementação das normas editadas pelo Ministro de Estado;***
>
> *(...)*
>
> ***XV - desenvolver, em conjunto com a Secretaria-Executiva, sistemas, mecanismos de gestão, de controle, de monitoramento e de avaliação das ações destinadas à organização e à implementação de redes de atenção especializada à saúde;***
>
> *(...)*
>
> ***XVII - definir diretrizes para as ações estruturantes e emergenciais da Força Nacional do SUS.***

81. Já a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde (SCITE) tem

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

como atribuição prevista no art. 30, do Decreto 9.795/2019:

> *Art. 30. À Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde compete:*
>
> *I - formular, coordenar, implementar e avaliar:*
>
> *a) a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;*
>
> *b) as **Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos**, inclusive de hemoderivados, vacinas, imunobiológicos e **outros insumos** relacionados como partes integrantes da Política Nacional de Saúde;*
>
> *c) a **Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde**; e*
>
> *d) a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde;*
>
> *(...)*
>
> *VI - participar da **formulação, da coordenação e da implementação das ações de regulação do mercado**, com vistas ao aprimoramento da Política Nacional de Saúde; **(grifo nosso)***

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

82. Diante do exposto, com as vênias de estilo, manifestamos concordância parcial com a Unidade Técnica, propondo, adicionalmente, a realização de:

a) audiências do Ministro da Saúde à época, Sr. Eduardo Pazuello; do Secretário da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS), Sr. Luiz Otávio Franco Duarte, e do Secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde (SCITE), Sr. Hélio Angotti Neto:

a.1) pela omissão em adotar medidas para implantação de sistema nacional de monitoramento de insumos críticos para uso no tratamento de pacientes com Covid-19, contribuindo para o agravamento da crise de abastecimento de oxigênio medicinal na cidade de Manaus/AM, em janeiro de 2021, apesar dos reiterados alertas proferidos pelo TCU para a adoção de medidas estratégicas, de coordenação e alinhamento, junto aos entes subnacionais, das diversas iniciativas e ações a cargo do Ministério da Saúde para enfrentamento da pandemia, incluindo o monitoramento de insumos críticos, considerando a existência de sinais claros de demanda crescente dos insumos no estado do Amazonas, especialmente em Manaus, desde abril de 2020, em descumprimento do papel institucional de governança daquele Ministério na condição de coordenador dos sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, conforme preceitua o art. 16, incisos III, alíneas "c" e "d", VI, X, XII, XIII, XIV e do parágrafo único vigente à época (hoje renumerado como § 1º), da Lei 8.080/1990 c/c os arts. 21, inciso XVIII, 23, inciso II, 200, incisos I e II, da Constituição Federal; art. 47, incisos II, IV e V, da Lei 13.844/2019; e art. 10, § 1º, inciso I, do Decreto 7.616, de 17 de novembro de 2011;

a.2) pela omissão em mapear riscos e buscar diagnósticos confiáveis diante das primeiras notícias de excepcional agravamento da pandemia no estado do Amazonas, e particularmente em Manaus, de forma a subsidiar uma resposta adequada e suficiente, que pudesse prevenir ou, ao menos, eficazmente mitigar o colapso do sistema de saúde local, conforme já se havia observado alguns meses antes e o qual acabou se materializando em meados de janeiro de 2021, em descumprimento aos mesmos diplomas legais citados na audiência anterior, acrescentando o descumprimento do art. 16, inciso XVII, da Lei 8.080/1990, e do art. 47, inciso VII, da Lei 13.844/2019.

83. Caso o relator entenda pertinente, encaminhar os autos à SecexSaúde, para manifestação sobre a possibilidade de inclusão de outros responsáveis na audiência acima sugerida, e, se for o

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

caso, de novas audiências para outras irregularidades (inclusive de outros gestores) que porventura a zelosa Unidade Técnica considere apropriadas, diante da abordagem dos fatos conferidas no presente parecer, com o posterior reenvio dos autos a este representante do Parquet.

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549975.

VOTO

Cuidam os autos de Representação efetuada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos e na prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em função da falta de fornecimento de oxigênio aos pacientes hospitalizados no estado do Amazonas em decorrência da covid-19, no mês de janeiro de 2021.

2. Trata-se, pois, da situação de colapso no sistema de saúde do estado do Amazonas, especialmente na rede de atenção de média e alta complexidade sob a responsabilidade do governo estadual e do governo federal, marcadamente pela falta de oxigênio medicinal para o atendimento emergencial de pacientes hospitalizados em função da covid-19.

3. Conforme amplamente noticiado na imprensa, a explosão no número de casos da doença em Manaus em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 ampliou significativamente a demanda por oxigênio medicinal, levando ao colapso no fornecimento desse produto e ao aumento de óbitos em razão da sua falta (nas primeiras oito semanas de 2021, teriam ocorrido no estado do Amazonas 113.732 casos e 5.506 óbitos em decorrência da covid-19 – peça 111, p. 266 e 267).

4. A situação extremamente crítica requereu a mobilização por parte do governo federal e de outros estados da federação no transporte para Manaus/AM de insumos, equipamentos e tanques de oxigênio líquido, e ainda no transporte de pacientes para outros estados, além de outras medidas emergenciais.

II

5. Consoante as informações e os documentos apresentados em diligência, a unidade técnica entendeu que a situação teve como causa a falta de controle e monitoramento do consumo de oxigênio pela secretaria estadual de saúde, a qual não dispunha de informações para tomar medidas preventivas e pedir apoio tempestivo para evitar ou mitigar o colapso do sistema.

6. Acerca do papel do Ministério da Saúde, a unidade técnica entendeu que o órgão não exerceu sua competência de controle e monitoramento dos insumos estratégicos a nível nacional, nos termos do artigo 16, inciso VI e § 1º, da Lei 8.080/1990 e artigo 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011.

7. Assim, em essência, foi proposta a expedição de determinação ao Ministério da Saúde, para que, no prazo de sessenta dias, "*elabore plano de ação, que especifique as ações a serem tomadas, seus responsáveis e os prazos para implementação, para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais ...*"

8. Instado a se manifestar por este Relator, o Ministério Público junto ao TCU apresenta entendimento divergente. Isso porque os elementos e evidências contidos nos autos apontariam para a existência de indícios de irregularidades atribuíveis aos então gestores do Ministério da Saúde.

9. Assim, o órgão ministerial propôs a realização de audiência dos seguintes gestores:

a) sr. Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde à época;

b) sr. Luiz Otávio Franco Duarte, então titular da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS); e

c) sr. Hélio Angotti Neto, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde (SCITE).

10. Os fatos imputados a tais responsáveis são:

a) omissão em adotar medidas para implantação de sistema nacional de monitoramento de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

insumos críticos para uso no tratamento de pacientes com covid-19, contribuindo para o agravamento da crise de abastecimento de oxigênio medicinal na cidade de Manaus/AM, em janeiro de 2021, apesar dos reiterados alertas proferidos pelo TCU para a adoção de medidas estratégicas, de coordenação e alinhamento, junto aos entes subnacionais; e

b) omissão em mapear riscos e buscar diagnósticos confiáveis diante das primeiras notícias de excepcional agravamento da pandemia no estado do Amazonas, e particularmente em Manaus, de forma a subsidiar uma resposta adequada e suficiente, que pudesse prevenir ou, ao menos, eficazmente mitigar o colapso do sistema de saúde local.

III

11. De inícios, analiso os acontecimentos que redundaram na mencionada crise de abastecimento de oxigênio no estado do Amazonas:

– em 23/12/2020, foram adotadas medidas sociais restritivas para impedir a disseminação do vírus, como o fechamento do comércio, evidenciando que o quadro de elevação de casos e o alarmante aumento da ocupação de leitos hospitalares era conhecido do governo estadual (em 27/12/2020, as medidas restritivas foram suprimidas em razão de suposta resistência social a respeito, peças 111, p. 262 e 107, p. 17);

– em 26/12/2020, o consumo diário de oxigênio medicinal era superior à capacidade produtiva da empresa White Martins – fornecedora de oxigênio medicinal para os hospitais no estado do Amazonas (peça 111, p. 285);

– em 27/12/2020, o portal G1 já noticiava um aumento de internações por covid-19 de 28% entre novembro e dezembro em Manaus/AM, com 88 novos registros de internação em um único dia – número equivalente àqueles observados em maio daquele mesmo ano, quando o estado do Amazonas viveu seu primeiro colapso do sistema público de saúde;

– em 28/12/2020, o Ministro da Saúde, ciente do aumento de hospitalizações na cidade de Manaus/AM, decidiu enviar, após a virada do ano, representante – Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro – para avaliar a situação (peça 113);

– em 29/12/2020, a taxa de ocupação do hospital de referência para o tratamento da doença na cidade estaria próxima de 100% (ocorreram no dia 112 novas internações, recorde até então) (peça 114, p. 9);

– em 30/12/2020, a Secretaria de Saúde do Amazonas solicitou ao Ministério o envio da Força Nacional do SUS para auxílio "*no monitoramento, orientação técnica, bem como operação local de suporte básico e avançado no atendimento à população que busca atendimento em Unidades de Saúde*" (peça 98, p. 2);

– em 3/1/2021, a equipe do Ministério da Saúde chegou ao estado (naquele momento, as internações haviam dobrado em uma semana) (peça 111, p. 264);

– em 4/1/2021, houve reunião entre a equipe do Ministério da Saúde, os chefes dos Poderes Executivos e os Secretários de Saúde do Estado do Amazonas e do Município de Manaus, na qual ficou registrada a possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em dez dias (não foram feitas menções específicas ao suprimento de oxigênio medicinal, pois foram feitas referências a dificuldades da aquisição de material de consumo hospitalar de uma forma geral) (peças 113, p. 3, e 111, p. 265);

– em 7/1/2021, a empresa White Martins informou aos representantes estaduais que, em razão dos altos índices de consumo de oxigênio, teria dificuldades logísticas para a entrega do produto, de forma que solicitou auxílio para trazer cilindros de Belém/PA (peças 81, p. 4, e 111, p. 291);

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

– em 7/1/2021 e 8/1/2021, o estado do Amazonas solicitou apoio logístico para transporte de cilindros de oxigênio (o Ministério da Saúde argumenta que essa solicitação ocorreu no dia 8/1/2021) (peças 19, 82 e 86);

– em 8/1/2021, a empresa White Martins informa à secretaria estadual de saúde sobre o aumento exponencial do consumo de gases e indica a empresa Carboxi como possível mantenedora do produto que poderia ser disponibilizado, em razão do estado de emergência (somente havia disponível 6.469 m³ na referida empresa) (peças 107, p. 23, e 107, p. 30);

– em 8/1/2021, a Força Nacional do SUS (Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde) confirma que lhe foi relatado o "*colapso de hospitais e falta da rede de oxigênio*" (peça 112, p. 171);

– em 9/1/2021, relatos de reuniões e vistorias da Força Nacional do SUS apontam colapso dos hospitais e falta da rede de oxigênio. Assim constou do relatório de visita técnica:

"*– Estão preferindo não medir a saturação dos pacientes na sala rosa 1, pois, ao medir, vários pacientes precisarão de oxigênio e não terão como suprir a demanda;*

– Os médicos estão decidindo quais pacientes entubar, quais ficarão no cuidado paliativo, quais pacientes podem ficar sem suporte semi intensivo, ou na sala vermelha entubados ou VNI, pois a demanda está muito maior que a capacidade instalada da unidade." (peças 111, p. 266-268, e 112, p. 179-180);

– em 10/1/2021, chegou a Manaus/AM a comitiva do Ministro da Saúde, composta pelo Secretário de Assistência Especializada, Secretário de Atenção Primária, Secretária de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, além de nova equipe técnica para apoio às ações e resposta ao estado do Amazonas (peça 81, p. 5);

– em 10/1/2021, o Governador do Amazonas encaminhou ofícios a todos os outros Governadores da Federação solicitando a disponibilização de estoque de oxigênio (peça 111, p. 297);

– em 11/1/2021, foi instituído um Comitê de Comando Conjunto, composto por representantes do estado do Amazonas, de membros da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e das Forças Armadas do Brasil (peça 81, p. 5);

– em 11/1/2021, o Ministro da Saúde teria se reunido com a empresa White Martins, após o que teria havido, já no dia seguinte, 12/1/2021, o primeiro suprimento de oxigênio líquido por meio de aeronave da FAB (peça 111, p. 268);

– em 13/1/2021, a empresa White Martins informou ao Comitê de Comando Conjunto que só teria oxigênio suficiente para abastecimento até as seis da manhã do dia seguinte (14/1), pois sua capacidade de fornecimento de oxigênio era de 25.000 m³/dia, ao passo que a necessidade diária das redes pública e privada de saúde ultrapassava o patamar de 76.500 m³/dia, perfazendo um déficit diário de 48.500 m³ (peça 81, p. 5-6, e 87);

– em 15/1/2021, autoridades estaduais e federais realizam a transferência de pacientes para outras regiões do país (peça 111, p. 305);

– em 16/1/2021, a Força Aérea Brasileira registrava mais de cem horas voadas e mais de 110 toneladas de carga transportada com destino à capital amazonense, havendo entregado, na madrugada de 16/1/2021, treze tanques de oxigênio líquido de grande porte, além de material hospitalar, cilindros de oxigênio, camas, tendas e gerador (peça 155, p. 115-116 do TC 025.828/2021-5);

– em 17/1/2021, o Ministério da Saúde divulgou que enviara sete usinas geradoras de oxigênio hospitalar por meio de aviões da Azul Linhas Aéreas (peça 155, p. 122, do TC

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

025.828/2021-5);

– em 20/1/2021, o estado do Amazonas recebeu cinco usinas para a produção de oxigênio líquido doadas pelo Hospital Sírio-Libanês e transportadas em aeronave da FAB (peça 155, p. 124, do TC 025.828/2021-5); e

– em 28/1/2021, o consumo de oxigênio medicinal na rede pública atinge o ápice de 73.686,20 m³/dia (o consumo médio no período de 1/6/2020 a 31/12/2020 foi de 14.315,60 m³/dia) (peça 81, p. 10).

IV

12. Tal qual exposto pela unidade técnica, verifica-que a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas era dependente de informações da fornecedora, a qual comunicou no dia 7/1/2021 as dificuldades logísticas para fornecimento e, no dia 13/1/2021, informou do desabastecimento iminente.

13. Ou seja, o órgão não dispunha de um sistema de controle para o monitoramento do consumo do insumo de forma a prever problemas no abastecimento. A própria resposta da secretaria à diligência efetuada por esta Corte confirma essa constatação (peça 81, p. 2):

"*justamente pela própria natureza do serviço, esta Secretaria de Estado de Saúde não exerce papel de "agência reguladora" estadual, de modo que não detém posse direta das referidas informações relacionadas à produção, consumo e distribuição dos gases medicinais, que pertencem exclusivamente às próprias empresas do setor*" (grifou-se).

14. Veja-se que as manifestações da secretaria estadual da saúde em datas próximas do colapso de fornecimento em 14/1/2021 não davam conta da gravidade da situação. Em ofício dirigido ao Comando Militar da Amazônia, em 8/1/2021, constava a seguinte solicitação (peça 86):

"*Cumpre-nos primeiramente esclarecer que, na data de hoje, esta Secretaria Requisitou Administrativamente 1 de outro fornecedor, Oxigênio Líquido Medicinal. De modo que, após, novo planejamento, constatou-se que a necessidade atual, será de apenas 350 (trezentos e cinquenta) unidades de cilindros com peso unitário de 70kg, desonerando os custos que este Comando teria com a operação anterior*." (grifou-se)

15. A razão para tanto é que, segundo a secretaria estadual de saúde, ao menos até aquela data (8/1/2021), "*em nenhum momento, a empresa White Martins citou a possibilidade de desabastecimento de oxigênio na rede, mas tão somente dificuldades logísticas pontuais e momentâneas*." (peça 81, p. 4).

16. Em outras palavras, o órgão não dispunha de informações para tomar medidas preventivas e pedir apoio tempestivo para evitar ou mitigar o colapso do sistema, o que pode caracterizar o descumprimento ao disposto no art. 17, incisos II e VIII da Lei 8.080/1990:

"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

...

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

...

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde;"

17. Em que pese essa inadequada dependência das informações do fornecedor para se avaliar as condições de consumo e fornecimento do insumo, cabe reconhecer que o volume necessário

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

para o atendimento à demanda em janeiro de 2021 foi, de certa forma, inesperado, até mesmo considerando-se a incidência da pandemia.

18. Isso porque, na primeira fase aguda da epidemia no estado do Amazonas, período de abril e maio de 2020, o pico de consumo alcançou 30.000 m³/dia. Enquanto, no segundo período crítico, a partir de janeiro de 2021, chegou a 73.686,20 m³/dia (peça 81, p. 10).

19. Há plausibilidade, portanto, na seguinte argumentação da secretaria estadual de saúde:

"em nenhum momento se cogitou falar em desabastecimento ou incapacidade produtiva de uma das maiores empresas de oxigênio medicinal e industrial do Brasil porque não havia e não houve, durante toda a primeira alça epidêmica, qualquer sinal, comunicado ou alerta da possibilidade de desabastecimento da rede estadual de saúde" (peça 81, p. 13).

20. A respeito, registro que, no novo plano de contingência estadual, foram alocadas responsabilidades para acompanhamento do consumo de oxigênio das unidades de saúde, demonstrando, portanto, a necessidade de controle e a responsabilidade da gestão estadual de saúde em ter números sobre controle e monitoramento.

21. De qualquer forma, constato que os recursos que suportaram as aquisições de oxigênio são recursos próprios do estado do Amazonas, motivo pelo qual entendo pertinente dar conhecimento do presente feito processual às instâncias regionais de controle.

V

22. Passo a tratar das ações do Ministério da Saúde.

23. A contratação, distribuição e consumo do oxigênio medicinal compete primeiramente aos entes subnacionais, os quais detêm a atribuição de gerir e executar os serviços públicos de saúde (arts. 17, inciso III, e 18, inciso I, da Lei 8.080/1990).

24. O papel do Ministério da Saúde é, primordialmente, fomentar as políticas públicas de saúde como órgão central, estando essas competências relacionadas no art. 16 da Lei 8.080/1990.

25. Em sendo assim, se era de responsabilidade primeira dos entes subnacionais monitorar o consumo de oxigênio medicinal e se estes não informaram tempestivamente ao Ministério da Saúde acerca de problemas no abastecimento do insumo, vislumbro, ao menos no presente momento processual, dificuldade em se responsabilizar os gestores do Ministério da Saúde especificamente sobre os problemas ocorridos no estado do Amazonas aqui tratados.

26. Veja-se que a partir do momento que o Ministério da Saúde tomou conhecimento da situação, foram adotadas medidas no sentido de sanar o problema. Por certo, diante da situação emergencial instalada, as medidas não tiveram efeito imediato e vidas foram perdidas até o normalizar da situação.

27. Relembro que, quando da primeira onda da pandemia, o consumo de oxigênio no estado do Amazonas foi bastante inferior ao verificado na segunda onda, de que agora se trata. A sistemática de monitoramento do consumo de oxigênio medicinal não só não havia sido adotada, como não se tinha tornado necessária até então. Ocorreu, de fato, uma situação inusitada e, em princípio, inesperada, pois foi em desacordo com os dados históricos de consumo.

28. Assim, nos moldes propostos pela unidade técnica, não vislumbro que, especificamente aos fatos aqui tratados, tenha havido dolo ou erro grosseiro na condução da crise por parte dos gestores do Ministério da Saúde.

29. São aplicáveis, a meu sentir, neste primeiro momento, as seguintes disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

"*Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente."

30. Na verdade, tal qual exposto pela unidade técnica, o colapso do sistema que levou ao desabastecimento de oxigênio ocorrido em Manaus, em janeiro de 2021, poderia ter ocorrido em qualquer outra época de pico, pretérito ou futuro, pois a falta de controle e monitoramento, seja pelo ente subnacional, seja pelo Ministério da Saúde, aumentou significativamente o risco de falta desse insumo.

31. Por outro lado, diante do caráter geral da situação, entendo que a conduta dos gestores do Ministério da Saúde em relação à adoção de ações de combate à pandemia deve ser analisada como um todo.

32. Passo a fazer considerações a respeito.

VI

33. Consoante o art. 16 da Lei 8.080/1990, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde, compete ao Ministério da Saúde, na condição de agente da União na direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS):

"Art. 16. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete

...

VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;

...

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais;

§ 1º A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional." (grifou-se)

34. Já de acordo com o art. 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011, que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN:

"*§ 1º São atribuições do representante do Ministério da Saúde designado para coordenar as medidas a serem executadas durante a ESPIN, nos termos do inciso III do caput do art. 10:*

I - planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde;

II - articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS;

...

IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN;" (grifou-se).

35. Por sua vez, o Decreto 9.795/2019, o qual aprova a estrutura organizacional do Ministério da Saúde, assim dispõe em seu anexo I:

"*Art. 1º O Ministério da Saúde, órgão da administração pública federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:*

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

...

II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde - SUS;"

"*Art. 24. Ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle compete:*

...

VI - monitorar e avaliar a assistência de média e alta complexidade quanto à capacidade operacional e potencial da rede instalada, à oferta de serviços de saúde e à execução dos recursos financeiros"

"Art. 35. Ao Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis compete:

"III - coordenar e executar as ações de epidemiologia e controle de doenças e agravos inusitados à saúde, de forma complementar ou suplementar em caráter excepcional, quando:

a) for superada a capacidade de execução dos Estados e do Distrito Federal;

b) houver o envolvimento de mais de um Estado e do Distrito Federal; ou

c) houver riscos de disseminação em âmbito nacional;" (grifou-se) .

36. Vê-se, pois, que ao Ministério da Saúde cabe uma posição de centralidade na adoção de esforços para a execução de ações de controle epidemiológico, como as que se referem ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.

37. Entretanto, em diversos acompanhamentos efetuados por este Tribunal, constatou-se a falta de uma estratégia de planejamento nacional para o enfrentamento da pandemia (voto condutor do Acórdão 2.817-Plenário, de 21/10/2020).

38. No bojo do Acórdão 1.873/2021-Plenário, de 4/8/2021, foi constatada a possível conduta omissiva dos gestores do Ministério da Saúde ao adotarem práticas não consistentes com o até então preconizado por este Tribunal.

39. Consoante o subitem 9.3 desse acórdão, foi determinada a realização de audiências dos gestores do Ministério da Saúde em razão do descumprimento de diversas determinações deste Tribunal.

40. Paralelamente, foi determinada a constituição de processo apartado para eventual apuração de responsabilidade dos gestores em razão da (subitem 9.4. do Acórdão 1.873/2021-Plenário):

- não implementação de medidas de comunicação efetivas para o combate à pandemia;

- omissão na implementação de medidas efetivas de assistência farmacêutica; e

- omissão na implementação de política nacional de testagem da covid-19.

41. Ora, de forma a preservar a visão de conjunto e avaliar adequadamente a condução da gestão do Ministério da Saúde, entendo pertinente que os fatos mencionados nos presentes autos sejam tratados naquele em que se avalia a conduta dos gestores como um todo. Assim, a ausência de monitoramento do consumo de oxigênio medicinal seria um dos tópicos desse processo.

42. Dito de outra forma, a novidade da situação e o seu caráter emergencial, conjugada com a multiplicidade de ações necessárias para o enfrentamento da pandemia, demanda que se averigue o conjunto de procedimentos adotados, sob pena de se ao analisar uma situação especifica, tirar-se conclusões que não condizem com o contexto da gestão e não reflitam as circunstâncias limitadoras vivenciadas pelos gestores à época da ocorrência dos fatos.

43. Considero, pois, adequada, a juntada dos presentes autos àquele de que trata o subitem 9.4. do Acórdão 1.873/2021-Plenário.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

44. Outrossim, acompanho a proposta de determinação para que sejam adotadas providências a respeito do tema aqui tratado.

VII

45. A unidade técnica também avaliou o contrato de fornecimento entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh e a empresa White Martins para o fornecimento de oxigênio ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

46. Foi constatado que nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021 houve a interrupção no fornecimento de oxigênio em desacordo com o estabelecido contratualmente (o abastecimento foi normalizado no dia 16 de janeiro de 2021). Cabe ressaltar que somente no mês de janeiro de 2021 foram consumidos pelo hospital 14.221 m^3 de oxigênio, equivalentes a 31,22% do consumo de todo o exercício de 2020 – 45.554 m^3. (peça 40, p. 4).

47. Posto isso, como foi aberto processo administrativo referente ao descumprimento contratual, acolho a proposta de determinação para que seja enviado a esta Corte o resultado de tal apuração.

VIII

48. Quanto às demais propostas de encaminhamento da unidade técnica, manifesto-me de acordo.

49. Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 30 de março de 2022.

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70549978.

ACÓRDÃO Nº 676/2022 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 000.344/2021-4.
1.1. Apenso: 006.259/2021-9
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em razão de possíveis irregularidades na gestão de recursos e na prestação de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), em função da falta de fornecimento de oxigênio aos pacientes hospitalizados no estado do Amazonas em decorrência da covid-19, no mês de janeiro de 2021,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal;

9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 16, incisos VI e XVII e parágrafo único, da Lei 8.080/1990; 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011 e 1º, inciso II, 24, inciso VI, e 35, inciso III, do Decreto 9.795/2019, que, no prazo de sessenta dias, elabore plano de ação para monitorar o abastecimento de oxigênio medicinal nos entes subnacionais, enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional;

9.3. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, assim que concluído, apresente ao Tribunal o resultado do processo de apuração do descumprimento parcial de contrato firmado com a empresa White Martins, pela falta de fornecimento contínuo de oxigênio, em janeiro de 2021, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV)/Ebserh;

9.4. determinar a juntada dos presentes autos àquele de que trata o subitem 9.4. do Acórdão 1.873/2021-Plenário;

9.5. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao Ministério Público do Estado do Amazonas;

9.6. dar ciência deste acórdão aos representantes de que trata o TC 000.463/2021-3.

10. Ata n° 11/2022 – Plenário.
11. Data da Sessão: 30/3/2022 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0676-11/22-P.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70558536.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Bruno Dantas, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 70558536.